LXXII. Egészségbiztosítási Alap

Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének végrehajtása

Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2014. évi költségvetési többlete 407,9 millió forint 1 907 617,5 millió forint bevételi és 1 907 209,6 millió forint kiadási főösszeg mellett.

Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása

Az E. Alap bevételi főösszege 1 907 617,5 millió forint, amely az előirányzatot 23 440,0 millió forinttal, 1,2 százalékkal haladja meg.

Az előirányzattól történő eltérés a következő tényezők együttes hatásából ered:

- a költségvetési hozzájárulások 25 437,0 millió forinttal, 2,8 százalékkal,
- a vagyongazdálkodás bevétele 4,4 millió forinttal

alacsonyabb;

- a járulékbevételek és hozzájárulások bevétele (ideértve az egészségügyi hozzájárulást is) – késedelmi pótlékkal együtt – 44 077,7 millió forinttal, 5,2 százalékkal,
- az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 314,0 millió forinttal, 4,0 százalékkal,
- a működési célú bevételek 489,7 millió forinttal

magasabb az eredeti előirányzatnál.

Az E. Alap bevételei összességében az előző évhez képest 59 484,9 millió forinttal, 3,2 százalékkal növekedtek az alábbi tényezők együttes hatásaként:

- a költségvetési hozzájárulások 69 720,5 millió forinttal, 7,2 százalékkal,
- a vagyongazdálkodásból származó bevételek 1,1 millió forinttal, 9,4 százalékkal,
- a működési célú bevételek 925,6 millió forinttal, 50,3 százalékkal

csökkent;

- a szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 81 579,0 millió forinttal,
- a biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevételek 28 361,6 millió forinttal, 4,9 százalékkal,
- az egyéb járulékok és hozzájárulások 4 325,0 millió forinttal, 10,6 százalékkal,
- az egészségügyi hozzájárulás 14 315,5 millió forinttal, 10,3 százalékkal,
- az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 230,6 millió forinttal, 1,1 százalékkal,
- a késedelmi pótlék és bírság 320,4 millió forinttal, 9,9 százalékkal

növekedett.

Járulékbevételek és hozzájárulások

A bevételek alakulását döntő mértékben meghatározó járulékbevételekből, hozzájárulásokból és késedelmi pótlékból 2014. évben 896 942,7 millió forint befizetés származott, amely az előirányzatnál 44 077,7 millió forinttal magasabb. A 2013. évi tényadathoz viszonyított növekedés 128 901,5 millió forint, amelyet az alább ismertetett változások okoztak.

Az E. Alapot megillető szociális hozzájárulási adóbevétel és munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek együttes tényadata 83 427,5 millió forint.

A bevételek közül 32,1 százalékot képviselő biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel alcím teljesítési adata 611 760,5 millió forint, amely az előirányzatnál 42 460,5 millió forinttal 7,5 százalékkal több, míg az előző évi tényszámot 28 361,6 millió forinttal, 4,9 százalékkal haladja meg. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke az előző évhez képest változatlan.

Az egyéb járulékokból és hozzájárulásokból együttesen 45 224,4 millió forint befizetés teljesült, amely az éves előirányzattól 709,4 millió forinttal, 1,6 százalékkal, a 2013. évi befizetéseknél 4 325,0 millió forinttal, 10,6 százalékkal magasabb.

Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak:

Az egészségügyi szolgáltatási járulék bevétele 27 657,2 millió forint, ami az előirányzattól 1 042,8 millió forinttal marad el, az előző évi tényszámhoz viszonyítva 2 342,8 millió forinttal, 9,3 százalékkal növekedett.

A megállapodás alapján fizetők járuléka 326,0 millió forint, amely az előirányzatot 36,0 millió forinttal, 12,4 százalékkal, az előző évi tényszámot 26,6 millió forinttal, 8,9 százalékkal haladja meg.

A munkáltatói táppénz hozzájárulás bevétele 17 053,9 millió forint, amely az éves előirányzatnál 1 943,9 millió forinttal, 12,9 százalékkal magasabb, az előző évi tényszámot 2 425,4 millió forinttal, 16,6 százalékkal haladja meg. Az előirányzat túllépését a táppénz-kiadások előirányzathoz viszonyított túlteljesülése indokolja.

Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher jogcím éves összege 178,6 millió forint, az előirányzatnál 63,6 millió forinttal, az előző évi tényszámnál 36,1 millió forinttal több.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések (START, START PLUSZ, START EXTRA kártyával foglalkoztatottak járulékkedvezmény megtérítése) jogcímen 8,7 millió forint bevétel került elszámolásra, amely az előirányzatnál 291,3 millió forinttal, az előző évi értékhez képest pedig 505,9 millió forinttal alacsonyabb.

Az egészségügyi hozzájárulás teljesítése 152 974,4 millió forint, az előirányzatnál 4 526,6 millió forinttal, 2,9 százalékkal kevesebb, az előző évi tényszámnál 14 315,5 millió forinttal, 10,3 százalékkal több.

A késedelmi pótlék, bírság összege 3 555,9 millió forint, amely az előirányzathoz képest 105,9 millió forinttal, 3,1 százalékkal, a 2013. évi tényszámhoz viszonyítva 320,4 millió forinttal, 9,9 százalékkal teljesült túl.

Költségvetési hozzájárulások

A költségvetési hozzájárulások éves bevétele 897 348,9 millió forint, amely az előirányzattól 25 437,0 millió forinttal, az előző évi tényszámnál 69 720,5 millió forinttal alacsonyabb.

Az alcímen belül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás – 5 400,0 millió forint – az előirányzat szintjén teljesült.

2014. évben a központi költségvetés az úgynevezett nemzeti kockázatközösség keretében havonta 5 790 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett – járulék címen átvett pénzeszköz címen – *a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről* szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj) 26. § (5) bekezdésében meghatározott személyek után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülők, fogva tartottak, szociálisan rászorulók, stb,), ennek éves teljesítési összege – az előirányzat szerinti – 370 413,3 millió forint volt.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz jogcímcsoporton 335 731,0 millió forint bevétele volt az E. Alapnak, amely – összhangban a kiadás teljesülésével – az előirányzatnál 9 269,0 millió forinttal 2,7 százalékkal alacsonyabb.

A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak a jogcímcsoport – 92 185,0 millió forint – az előirányzat szintjén teljesült.

A tervezett pénzeszköz-átvétel jogcímcsoport teljesítése 93 619,6 millió forint, amely 16 168,0 millió forinttal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az előirányzat az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1a) bekezdésének b) pontjának megfelelően az E. Alap *Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről* szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a továbbiakban: Kt.) szereplő pénzforgalmi egyenlegét biztosítja (a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezésének és az utolsó ellátás kifizetésének figyelembe vételével).

Ellátások fedezetéül szolgáló egyéb bevételek

Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcímen a 2014. évben befizetett bevételek együttes összege 112 401,0 millió forint volt, amely az előirányzat összegét 4 314,0 millió forinttal, 4,0 százalékkal haladta meg.

Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak:
A terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 515,1 millió forint, az előirányzatnál 29,9 millió forinttal, 5,5 százalékkal, az előző évi tényszámnál 21,8 millió forinttal, 4,1 százalékkal kevesebb.

A baleseti és egyéb kártérítési megtérítésekből 6 184,6 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatnál 484,6 millió forinttal, 8,5 százalékkal, a 2013. évi tényadatnál 394,8 millió forinttal, 6,8 százalékkal lett magasabb. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás keretében az E. Alapot megillető megtérítés összege 4 372,1 millió forint volt.

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek címen 1 414,8 millió forint befizetés történt, ami az előirányzatnál 85,2 millió forinttal, 5,7 százalékkal, az előző évi tényszámnál 1 260,6 millió forinttal, 47,1 százalékkal kevesebb. A jogcímcsoport csökkenését a jogalap nélkül felvett vagy más ok miatti visszafizetések megtérítéséből származó, Ny. Alapnál keletkezett, de az E. Alapot illető bevételek csökkenése okozta.

A gyógyszergyártók és gyógyszerforgalmazók befizetéséből 57 408,0 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatot 1 408,0 millió forinttal, 2,5 százalékkal haladta meg, az előző évi értéknél 1 276,0 millió forinttal, 2,2 százalékkal kevesebb. A változásban szerepet játszott a 20,0 százalékos gyártói befizetés növekedése, illetve a kiegészítő gyártói befizetés, a gyógyszerismertetők után fizetendő díj és a támogatásvolumen szerződések alapján fizetett befizetések csökkenése.

Az E. Alapot 2014. évben 6 861,9 millió forint a gyógyszergyártókkal kötött szerződések (pl. támogatásvolumen) révén, valamint 50 546,1 millió forint a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszertártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos befizetések alapján illette meg. A gyógyszerforgalmazás utáni befizetések jogcím magában foglalja a 20,0 százalékos, 10,0 százalékos (spanyol modell) befizetési kötelezettségeken túl a gyógyszerismertetők utáni, valamint a nagykereskedők befizetéseit is. Sávos befizetési kötelezettség 2014. évben nem volt.

A nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítéséből származó bevétel 2 654,8 millió forint, amely az előirányzatnál 552,8 millió forinttal, az előző évi befizetés összegénél 1 118,5 millió forinttal több.

A jogcímek magukban foglalják az EGT tagállamokból érkező biztosítottak Magyarországon E jelű formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet a benyújtott költségigények alapján térítenek meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére a külföldi biztosítók (külföldiek magyarországi ellátása közösségi szabály alapján). A magyar-horvát, magyar-montenegrói, magyar-bosnyák és magyar-szerb egyezmények alapján magyarországi ellátások kifizetése a horvát, montenegrói, bosnyák és szerb biztosítottak magyarországi sürgősségi ellátásait tartalmazza.

Az egészségügyi szolgáltatók visszafizetéséből 368,6 millió forint bevétel keletkezett, amely az előirányzatnál 168,6 millió forinttal, a 2013. évi teljesítésnél 188,1 millió forinttal több. A visszafizetésből 153,7 millió forint kapcsolódott a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekhez, míg 214,7 millió forint az egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése alapján illette meg az Alapot.

A baleseti adóból 23 812,0 millió forint befizetés teljesült, amely az éves előirányzatnál 772,0 millió forinttal, 3,4 százalékkal, az előző évi tényszámnál 941,7 millió forinttal, 4,1 százalékkal több.

A népegészségügyi termékadó címen 20 043,1 millió forint bevétele származott az E. Alapnak, amely az előirányzathoz viszonyítva 1 043,1 millió forinttal 5,5 százalékkal, az előző évi tényszámnál 1 145,9 millió forinttal, 6,1 százalékkal több.

Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás bevételi előirányzata 15,0 millió forint volt, ténylegesen 10,6 millió forint realizálódott. 2008. január 1-jétől az ÁPV Zrt. és a KVI jogutódja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) végzi a vagyon kezelését. Az előirányzattól való eltérés oka az, hogy az MNV Zrt. nem teljes körűen értékesítette a meglévő vagyonelemeket.

Működési célú bevételek

Az OEP központi szerv 2014. évi eredeti bevételi előirányzata 424,6 millió forint, amely összeg év közben 569,2 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 993,8 millió forint. A teljesítési adat 914,3 millió forint, amely 489,7 millió forinttal több, mint az eredeti előirányzat.

adatok millió forintban

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi törvényi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. az eredeti előirányzat %-ában
Egészségbiztosítási költségvetési szervek bevételei	**1 839,9**	**424,6**	**993,8**	**914,3**	**215,3**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498,6		262,2	182,7	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	785,9		149,7	149,7	
Közhatalmi bevételek	296,2	254,6	283,0	283,1	111,2
Működési bevételek	155,0	170,0	175,8	175,7	103,4
Működési célú átvett pénzeszközök	43,3		75,6	75,6	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60,9		47,5	47,5	

Többletbevétel a közhatalmi és működési bevételeknél, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközöknél, továbbá a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök című soron keletkezett.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata – amely tartalmazza a közhatalmi bevételeket is – 424,6 millió forint. A módosított előirányzat 458,8 millió forint, amely a többletbevételek 34,2 millió forint összegű előirányzatosításából adódott.

Az OEP központi hivatali szerve 458,8 millió forint összegű közhatalmi és működési bevételt realizált. A bevétel 50,2 százaléka – 283,1 millió forint – igazgatási szolgáltatási díj jogcímen keletkezett, melyből gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz befogadás díjbevétele 277,7 millió forint, 5,4 millió forint a keresőképtelenség felülvizsgálati díja.

A fennmaradó 175,7 millió forint működési bevételek közül a beszámolási időszakban a legjelentősebbek:

- gépi adatszolgáltatás nyújtásával 53,2 millió forint bevétel,
- a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, valamint fordított ÁFA miatti bevétel, illetve ÁFA visszatérülés 22,2 millió forint általános forgalmi adó bevétele,
- továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) bevételéből 16,4 millió forint,
- helyiség bérbeadásából származó díjak bevétele 12,8 millió forint,
- üdültetés bevételéből 14,9 millió forint,
- biztosítók által fizetett kártérítésből 6,1 millió forint,

- gépkocsi használat, mobil telefon túllépés bevételéből 5,4 millió forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 182,7 millió forint.

Támogatásértékű bevétel

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kereset-kiegészítésének finanszírozására jóváhagyott 47,0 millió forint,
- *a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól* szóló 8/2005. (II.8) PM rendelet alapján elrendelt 53,8 millió forint munkáltatói kifizetések támogatásából,
- az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 71,6 millió forint finanszírozásából, továbbá
- az Államreform Operatív Program (ÁROP) kapcsán 10,3 millió forint támogatásából származott.

A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérést az európai uniós támogatások (EKOP, ÁROP projektek) előirányzatosítása okozza. A 2014. évi kifizetési kérelmekben finanszírozásra benyújtott az OEP által megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódó bevétel került előirányzatosításra, amely 2014. évben nem folyt be teljes összegben.

A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről soron az EURIPID projekt támogatására jóváhagyott 75,6 millió forint szerepel. A projekt a nemzetközi gyógyszerárak összehasonlításához szükséges fejlesztések informatikai részének forrását biztosítja.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 149,7 millió forint, az EKOP Projekt szállítói finanszírozása.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 47,5 millió forint, amely az alábbi bevételekből tevődik össze:

- a dolgozóknak korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülése 35,3 millió forint,
- *az államháztartás számviteléről szóló* 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet 49. § alapján, továbbá *az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló* 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a lakásépítés- és vásárlás munkáltatói számla nem számolható el idegen pénzeszközként, ezért a 2014. január 1-jei nyitóegyenleg, 12,2 millió forint egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként szerepel az intézményi költségvetésben.

A 2014. évi teljesítés (914,3 millió forint) és a módosított előirányzat (993,8 millió forint) 79,5 millió forint összegű eltérése az európai uniós támogatások előirányzatosítása okozza, mely előirányzatosított bevétel 2014. évben nem folyt be teljes összegben.

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak alakulása

Az E. Alap 2014. évi kiadási főösszege 1 907 209,6 millió forint, amely az eredeti előirányzatnál 23 032,1 millió forinttal, 1,2 százalékkal, az előző évi kiadásnál 58 564,2 millió forinttal, 3,2 százalékkal magasabb.

Pénzbeli ellátások

A Kt. az E. Alap pénzbeli ellátásaira vonatkozóan 561 900,0 millió forintot irányzott elő. A tárgyévi teljesítés 559 065,1 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatnál 2 834,9 millió forinttal, 0,5 százalékkal kevesebb, az előző évi teljesítésnél 5 627,7 millió forinttal több.

A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainál az előirányzat 2014. évre 37 500,0 millió forint volt, a kifizetés 41 412,3 millió forintban teljesült. Az előző évhez viszonyított 3 142,5 millió forintos kiadás-növekedést (8,2 százalék) a következő tényezők együttesen okozták:

- az egy segélyezési napra jutó kiadás – az előző évinél kisebb mértékű – 4,4 százalékos emelkedése,
- az igénybevevők havi átlagos száma az előző évhez képest 2,2 százalékkal (523 fő) nőtt,
- a segélyezési napok száma 3,8 százalékkal (312,2 ezer nap) nőtt.

A 2014. évi költségvetésben a táppénz együttes eredeti előirányzata 63 000,0 millió forint, a ténylegesen táppénzre fordított kiadás ennél 8,2 százalékkal több, azaz 68 190,3 millió forint.

Az előző évi kiadáshoz (59 873,7 millió forint) viszonyított 8 316,6 millió forintos (13,9 százalék) kiadás-növekedés összetevői a következők:

- a táppénzes napok száma (2014. évben 21 565,4 ezer nap) 2013. évhez képest 8,9 százalékkal több;
- az egy napra jutó táppénzkiadás (2014. évben 3 082 forint volt), 2013. évhez képest 5,2 százalékkal növekedett;
- a táppénzesek napi átlagos létszáma (2014. évben 59 083 fő) – a táppénzes napok növekedésének megfelelően – 8,9 százalékkal nőtt.

A táppénzes adatok statisztikai adatgyűjtésből származnak, és nem tartalmazzák a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifizetőhelyeinek a hivatásos, valamint a Magyar Honvédség szerződéses állományához tartozók, továbbá a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák statisztikai adatait.

2014-ben a táppénz maximuma 6 766,7 Ft/nap (a minimálbér - 101 500 forint - 200 százalékának harmincad része) volt, ez 2013. évben 6 533,3 Ft/nap volt.

A 68 190,3 millió forint kiadási összegből a baleseti táppénzre fordított kiadás 7 292,3 millió forint. A baleseti táppénz kiadás az előirányzatnál 652,7 millió forinttal, 9,8 százalékkal magasabb. A baleseti táppénz aránya az összes táppénzkiadáson belül 10,7 százalék, ami megegyezik az előző évi aránnyal. A 2013. évhez viszonyított kiadásnövekedés az egy táppénzes napra jutó kiadás (2014. évben 5 582 forint) 5,0 százalékos növekedése és a baleseti táppénzes napok számának 7,3 százalékos emelkedése mellett következett be.

Az összes táppénzes kiadásból a gyermekápolási táppénz 2 864,0 millió forint, amely az előirányzatnál 394,3 millió forinttal, 16,0 százalékkal több. A gyermekápolási táppénz aránya az összes táppénzkiadáson belül 4,2 százalék, ami 0,3 százalékponttal magasabb az előző évinél. A gyermekápolási táppénzkiadás 2013. évhez viszonyított növekedése az egy táppénzes napra jutó kiadás (3 079 forint), 1,8 százalékos növekedése, valamint a táppénzes esetek 21,1 százalékos, illetve a napok 20,0 százalékos emelkedése mellett következett be.

A betegséggel kapcsolatos segélyekkel összefüggő egyszeri segély éves teljesítése megegyezik a 2014. évi előirányzat összegével (450,0 millió forint).

2014. évben 30 573 db segélykérelem érkezett országosan. Az előző évről áthozott el nem bírált kérelmekkel együtt a kérelmek száma 32 685 darab volt. Országos szinten a beérkezett kérelmek 63,5 százaléka került teljesítésre. 1 538 kérelemben nem született döntés, melyek elbírálására 2015. január és február hónapban került sor. Az egy főre jutó segély összegének átlaga országosan 23 715 forint volt. 8 161 db kérelem került elutasításra.

A kártérítési járadék 2014. évi tényadata 856,4 millió forint, az előirányzatnál 43,6 millió forinttal, 4,8 százalékkal kevesebb. Kártérítési járadékban havonta átlagosan 2 853 fő részesült, 211 fővel kevesebb, mint 2013. évben. Több éve tartó trend, miszerint csökken az ellátásban részesülők száma. Az egy főre jutó ellátás havi átlagos összege 25 011 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 861 forint, 3,6 százalék.

Baleseti járadék címen 8 449,0 millió forint került kifizetésre, amely az előirányzatnál 251,0 millió forinttal, 2,9 százalékkal kevesebb. Baleseti járadékban átlagosan, havonta 26 945 fő részesült, amely 922 fővel kevesebb, mint az előző évben. Az egy főre jutó ellátás havi átlagos összege 26 130 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 650 forint, 2,6 százalék.

A gyermekgondozási díj kiadásának előirányzata 106 350,0 millió forint, a teljesítés 104 163,7 millió forint volt, amely az előirányzattól 2 186,3 millió forinttal 2,1 százalékkal elmaradt.

Az ellátás összegét a törvény a minimálbér kétszeresének 70,0 százalékában maximalizálja, ami a 2014. évben bruttó 142 100 forint.

Az előző évhez viszonyított kiadásnövekedést (11,4 százalék) a következő tényezők együttesen okozták:

- az igénybevevők átlagos száma 83 701 fő/hóra (3,0 százalékkal) nőtt;
- az egy napra jutó kiadás (2013. évben 3 288 forint) 7,7 százalékkal, 3 542 forintra emelkedett; a kiadások növekedésében közrejátszott a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló átlagkeresetek növekedése, és a minimálbér emelkedése következtében megnőtt GYED maximális összege.

A minimálbéremelésen kívül, a 2014. január 1-jétől bekövetkező jogszabály-módosítások is hatást gyakoroltak a pénzbeli ellátások kiadásaira. A GYED extra néven ismertté vált intézkedéscsomag leglényegesebb elemei, hogy

- a gyermek egy éves kora után a szülő visszamehet dolgozni anélkül, hogy le kellene mondania az ellátás folyósításáról,
- különböző korú gyermekek esetén folyósítható vált egyidejűleg több ellátás,
- ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj további 1 évig folyósítható,
- bevezetésre került az úgynevezett diplomás gyermekgondozási díj intézménye.

Méltányossági jogkörben engedélyezhető valamennyi pénzbeli ellátásra 170,0 millió forint keret állt rendelkezésre a 2014. évben is. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 156,2 millió forint a teljesítés összege, amely a keret 91,8 százaléka. A kiadások 24,9 százalékát (57,6 millió forint) a táppénz jogcímen igénybevett ellátások tették ki. (A gyermek ápolása címén kérelmezett, méltányosságból engedélyezett táppénz kiadás 15,3 millió forint volt.) Méltányossági jogkörben Terhességi-gyermekágyi segélyre 2014-ben 43,5 millió forint kiadás teljesült, amely a keret 25,6 százaléka, míg Gyermekgondozási díj esetében 55,1 millió forint került kifizetésre.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzata 345 000,0 millió forint, a teljesítés 335 543,4 millió forint volt, az előirányzattól 2,7 százalékkal maradt el. Az előző évhez viszonyított 4,2 százalékos kiadáscsökkenést – többek között – az alábbi tényezők együttesen okozták:

- az igénybevevők átlagos száma csökkent;

- a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről szóló 494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, továbbá a bányászok egészségkárosodási járadéka a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező mértékben (2,4 százalékkal) emelkedett.

Természetbeni ellátások kiadásai

A természetbeni ellátások eredeti előirányzata 1 300 275,4 millió forint, a teljesítés 1 325 520,7 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatnál 1,9 százalékkal (25 245,3 millió forinttal) magasabb. Az előző évhez képest az emelkedés 53 803,8 millió forint, 4,2 százalék.

Gyógyító-megelőző ellátások kiadása

A Kt. a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport eredeti előirányzatát együttesen 931 870,2 millió forintban határozta meg.

A jogcímcsoport 2014. évi törvényi előirányzatai nem módosultak, ugyanakkor miniszteri hatáskörben év közben átcsoportosítások történtek, továbbá Kormány és miniszteri hatáskörben együttesen 13 800,0 millió forint külső forrás bevonására került sor. Ennek eredményeképpen a jogcímcsoport előirányzata 945 670,2 millió forintra emelkedett, az éves kifizetés 945 649,2 millió forint volt.

A Kt. 20. § (2) bekezdése szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5 000,0 millió forintot tartalmaztak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

A 2014-es évben az ellátásokon belül az alapellátásban új finanszírozási elemek bevezetésére került sor:

- **Szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetése**. Új elemként jelent meg a háziorvosi ellátás finanszírozásában; a szolgálatokban – legalább heti 20 órás munkaidőben – alkalmazott szakdolgozónként, meghatározott összegű (10-20 000 forint/hó) díjazásra jogosult a háziorvosi szolgáltató. Ezen intézkedés végrehajtására 1 800,0 millió forint pluszforrás állt rendelkezésre.

- **Hátrányos helyzetű településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálatok kiegészítő díjazása.** Az *egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról* szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel módosított, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Kr.) 23. § (2b) bekezdése alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálat – szolgálatonként – havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult.

A kiegészítő díj kiutalására a 2014. március havi utalás során, január hónapra visszamenőleges hatállyal került sor.

Előirányzatok évközi módosításai

Béremelés fedezete

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató *az* egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét elektronikus úton nyújthatja be a GYEMSZI részére.

A támogatás fedezetéül a Kr. 5. számú melléklete szerinti célelőirányzatok jogcímen belül 53 486,9 millió forint állt rendelkezésre az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete előirányzaton.
A szakellátásban 2012-ben megkezdett bérfejlesztés fedezeteként 2014-ben a GYEMSZI havi adatszolgáltatása alapján összesen 51 375,9 millió forint volt a kifizetés.

Egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára 2014-ben is igényelhetett támogatást.

A 7 875,8 millió forint éves jövedelem-kiegészítés kiutalására a GYEMSZI havi adatszolgáltatása alapján került sor.
A tervezett éves kifizetés nagyságrendjének ismeretében az év elején 5 000,0 millió forinttal csökkent a kassza éves előirányzata az összevont szakellátás javára.

Alapellátás fejlesztése

A háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímén 10 000,0 millió forint állt rendelkezésre az alapellátás területén felmerült fejlesztési igények fedezetére.

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, fejlesztésre elkülönített forrásából 1 750,0 millió forint a védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím előirányzatára, 1 500,0 millió forint a fogászati ellátás jogcím előirányzatára, 750,0 millió forint a célelőirányzatok jogcímre került átcsoportosításra.

A védőnői ellátás 1 750,0 millió forintos előirányzat-növelése a szolgálatok fix díjainak és a gondozotti létszámhoz igazodó Ft/pont értéknek az emelésére biztosított – január hónapra visszamenőleges hatállyal – fedezetet. A havi finanszírozási díj 145,8 millió forinttal növekedett.

A fogászati ellátás 1 500,0 millió forintos előirányzat-növelése a hátrányos helyzetű településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálatok kiegészítő díjazására (816,0 millió forint), továbbá az egyes fogászati prevenciós és szűrés keretébe tartozó fogászati beavatkozások pontértékének emelésére (684,0 millió forint) szolgált.

Háziorvosi letelepedési és a szolgálatok együttműködési támogatásának elkülönített kerete 750,0 millió forint volt. A Kr. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására az OEP 2014. augusztus 1-jén pályázatot írt ki.

Pályázatot az az orvos nyújthatott be, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalta, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

Az elnyerhető támogatási összeg 6,0 - 10,0 millió forint között mozgott annak függvényében, hogy mennyi ideje betöltetlen a háziorvosi szolgálat. Az OEP-hez benyújtott 46 pályázatból 41 kapott nyertes minősítést, de végül mindösszesen 38 háziorvossal kötött finanszírozási és támogatási szerződést az OEP, a kiutalt támogatási összeg 412,8 millió forint volt.

Az alapellátás fejlesztési keretéből az előzőekben tárgyalt 3 ellátási formára történt együttesen 4 000,0 millió forint átcsoportosítását követően a háziorvosi ellátás előirányzatán fennmaradó 6 000,0 millió forint többletforrás az év során három különböző jogcímen került felhasználásra. A háziorvosi szolgálatok teljesítménydíjazásának (Ft/pont érték) emelését 2 400,0 millió forint, míg a szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetését 1 800,0 millió forint szolgálta. A háziorvosi indikátorrendszer díjazásának éves összege szintén 1 800,0 millió forinttal emelkedett.

Működési támogatás

Az intézkedés célja az egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények gazdálkodásának javítása, az érintett szolgáltatók 2014. évi lejárt szállítói állományuk, köztartozásuk részleges kezelésével, továbbá a betegszállítás és a mentés megnövekedett működési költségigényének egyszeri kompenzálása. A kiutalások fedezetének biztosítása két forrásból történt.
Az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről szóló 1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 millió forint előirányzatának teljes összege átcsoportosításra került a célelőirányzatokon belül újonnan létrehozott működési támogatás előirányzat javára.

Miniszteri hatáskörben további együttesen 3 800,0 millió forint előirányzat-átcsoportosításra is szükség volt, melynek során a Célelőirányzatok jogcím (ezen belül a működési támogatás) előirányzata további 1 835,5 millió forinttal emelkedett. A fennmaradó összegből 500,0 millió forint a mentést, 150,0 millió forint a betegszállítást végző szolgáltatók likviditásának (működési feltételeinek) javítását szolgálta egyszeri kiegészítő díjazásként, továbbá az aktív fekvőbeteg szakellátás miniszteri keretének emelésére biztosított 1 314,5 millió forint összegben többletforrást.

A működési támogatás fedezeteként összesen 11 835,5 millió forint állt rendelkezésre, melynek a felhasználására és az elszámolására vonatkozó részletes szabályokat *a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról* szóló 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet tartalmazta.

A támogatás teljes összegének kiutalására július hónapban került sor, ugyanakkor az év hátralévő időszakában 12 szolgáltató fel nem használt támogatásként együttesen 103,5 millió forintot térített vissza.

Év végi maradvány kifizetése

A december havi finanszírozás, illetve a tervezett hóközi kiutalások figyelembe vételével került sor az év utolsó előirányzat-átcsoportosítására. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 2014. év végi maradványa 9 853,0 millió forint volt, melyet a Kormány az alábbi határozatában további 10 000,0 millió forinttal megemelt.

Speciális finanszírozású szakellátás külső forrásbevonása
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló

1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat az összevont szakellátás jogcím előirányzatát 10 000,0 millió forinttal emelte meg.

A keretnövelés elsődleges célja az onkológia készítmények és életmentő kardiológiai eszközök, továbbá a súlyos reumatológiai, gasztroenterológiai, speciális immunológiai megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek finanszírozására történő többletforrás biztosítása volt, ezért a külső forrásbevonás teljes összegével a speciális finanszírozású szakellátás előirányzata emelkedett.

A gyógyító-megelőző ellátás egyes jogcímein jelentkező összesen 19 853,0 millió forint előirányzat-maradvány felosztása az alábbi szempontok szerint történt:

- A 2013. évi konszolidációs támogatási összeg visszafizetésére kötelezett intézmények számára, likviditásuk megőrzése érdekében: 353,0 millió forint;

- egyéb ellátási érdek alapján meghatározott intézményi kör részére: 240,0 millió forint.

- A GYEMSZI által átvett, korábban nonprofit gazdasági társaság formában működő kórházak dolgozóinak járó, visszamenőleges jubileumi jutalmak fedezetére: 535,0 millió forint;

- az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és fogászati praxisok számára 320,0 millió forint, mely praxisonként egységesen 105 000 forint kifizetést tett lehetővé;

- az aktív fekvőbeteg ellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók 100-104 százalékos degressziós sávban elszámolt teljesítménydíj kiegészítése 100 százalékos alapdíjon – a 2014. augusztusi kifizetések figyelembe vételével – történő elszámolására: 1 416,0 millió forint;

- ugyanezen szolgáltatói kör számára teljesítményarányos felosztásra: 6 989,0 millió forint**,** azzal, hogy szolgáltatói szinten a megállapított összeget a várólista csökkentésre meghatározott összeggel (de maximum a megállapított összeg erejéig) csökkenteni kell;

- onkológia készítmények, életmentő kardiológiai, szívsebészeti eszközök, továbbá a súlyos reumatológiai, gasztroenterológiai, speciális immunológiai megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek és korszerű biológiai eredetű gyógyszerek finanszírozására: 10 000,0 millió forint.

Az OEP intézkedése alapján a maradvány összeg kiutalása 2014. december 30. napján megtörtént.

Járandóság előleg

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (5) bekezdése alapján: *„A kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi*

b) az Egészségbiztosítási Alap által a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók havi finanszírozási összegének jogszabályban meghatározott részét a szolgáltatók kérelme alapján az Egészségbiztosítási Alap kezelő szervének kezdeményezésére, ha jogszabályban előírt kifizetési időpont teljesítéséhez ez szükséges,”.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a szolgáltatóknak az előlegigénylésre vonatkozó bejelentésüket az illetékes Területi Hivatalnál kellett megtenniük, az e célra rendszeresített Igénybejelentő lapon.

E jogcímen *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 123. § (8) bekezdés alapján az érintett szolgáltatók utalási évre vonatkozó 12 havi finanszírozási összegéből számított havi átlagának 40,0 százaléka volt kiutalható. Az előleget az OEP-nek – mindkét finanszírozási kör esetében – egy összegben, a január első munkanapján esedékes finanszírozási összeg utalásánál kellett visszavonni.

A nettó és bruttó körbe tartozó szolgáltatók által benyújtott kérelem alapján kiutalt 2014. évi járandóság előleg

Megnevezés	**Intézmények száma (db)**	**Kiutalt összeg (millió forint)**
Nettó kör	12	182,3
Bruttó kör	87	12 596,4
Összesen	**99**	**12 778,7**

Működési költségelőleg

Az Ebtv. 35. §-ának (4) bekezdése alapján, a Kr. 6/A. §-a szerinti finanszírozási előlegben – a költségvetés e célra szolgáló előirányzata terhére – az előző évi 18 szolgáltatóval szemben 15 szolgáltató részesült.

A kassza éves keretének felhasználására vonatkozó szabályok szerint az év közben, a szolgáltatók egyedi kérelme alapján, az OEP főigazgatójának engedélyével kifizetett előleget a tárgyévben vissza kell fizetni. A működési költségelőleg maximálisan adható összege a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagösszeg 30,0 százaléka.

A Kr. 6/F. §-a alapján a működési költségelőleg előirányzata terhére a gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozási szabályainak módosulása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára – a betegellátás zavartalansága érdekében – előleg folyósítható. E jogcímen 2014. évben, hasonlóan az előző évhez nem történt kifizetés.

Az előző évhez viszonyítva 2014. évben tovább csökkent az igénylők száma és a kiutalt előlegek összege. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően együttesen 1 348,3 millió forint évközi kifizetésre került sor, melynek visszavonása év végéig megtörtént.

Jogviszony-ellenőrzés

A *kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló* 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. § rendelkezései alapján a – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – valamennyi szolgáltató köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően ellenőrizni az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultságot (jogviszonyt). Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

Amennyiben a szolgáltató az ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette, akkor a Kr. 4/A. §-a alapján az adott ellátás után járó finanszírozási összegnek csak a 90 százalékára jogosult; a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgáltatók esetében a meghatározott országos átlagos esetdíj 10,0 százaléka, illetve a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10,0 százaléka – legfeljebb 1000 forint – kerül levonásra a díjazásból.

Az ellenőrzési kötelezettségteljesítése esetén a szolgáltató ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül:

- háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti és fogorvosi alapellátás ellátás esetében az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása,

- járóbeteg-szakellátás esetében egy biztosított egy egészségügyi szolgáltatónál egy napon történt ellátása,

- fekvőbeteg-szakellátás esetében ápolási esetenként az ellenőrzés elvégzésére meghatározott nap.

A jogviszony ellenőrzési díjat a havi finanszírozás keretében kell kifizetni.

Mind a jogviszony ellenőrzés díjazása tekintetében, mind a szankcionálás miatti levonás összegének nagyságában jelentős változás az előző év azonos időszakához képest nem történt.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 2014-ben a visszavonás összesen 181,9 millió forint, míg a kifizetés 5 383,6 millió forint volt.

Összességében a jogviszony ellenőrzéshez kapcsolódó szankcionálások és kifizetések egyenlege 5 201,7 millió forint volt, mely 1,2 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A Kt. 20. § (2) bekezdése alapján: „A LXXII. *Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5 000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.*" E forrás szolgált többek között a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), a Regionális Operatív Programok (ROP), illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében – befogadott, valamint a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13-15/A. § szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás keretében befogadott többletkapacitásokra.

Az előzetesen befogadott többletkapacitásokra vonatkozó TVK megállapítása a Kr. 27/A. § (4) bekezdése alapján történt. Ezen szabályok alapján a TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik, és amennyiben a szolgáltató az adott szakmában már rendelkezik kapacitással, úgy az egy kapacitásegységre jutó, adott szakmára jellemző országos átlag és az intézményi átlag közül a magasabbat kell figyelembe venni.

A beszámolás időszak alatt az uniós forrásokból megvalósuló TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott többletkapacitásokra aktív fekvőbeteg szakellátás vonatkozásában két szolgáltató esetében került sor - sürgősségi betegellátási tevékenység fejlesztésére – szerződéskötésre, egynapos ellátás végzésére pedig egy új szolgáltató nyert befogadást. A rehabilitációs ellátások fejlesztésére befogadott szolgáltatók közül két szolgáltatóval került a szerződés megkötésre. Járóbeteg-szakellátási többlet-kapacitásokra 11 szolgáltatóval történt szerződéskötés.
Egy újonnan létrejövő egészségügyi szolgáltató volt, a többi esetben a meglévő szakmák és az ahhoz tartozó kapacitások bővítésére került sor. Ezen túlmenően egy szolgáltatóval történt MRI készülék finanszírozására-, és két szolgáltatóval CT készülék finanszírozására szerződéskötés. Otthoni szakápolásra vonatkozóan a 2014. évben egy szolgáltatóval került sor szerződéskötésre.

Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP 6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggően előzetes többletkapacitás befogadás keretében közfinanszírozott szolgáltatók nyertek lehetőséget egyéni, valamint csoportos dohányzás leszoktatást célzó indexes OENO-k végzésére, többlet óraszám befogadása mellett. A beszámolási időszak alatt egyéni leszoktatás tevékenységre 66 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés, melyből egy szolgáltatóval ugyanebben az évben e tevékenységre vonatkozóan meg is szűnt a finanszírozási szerződés. A csoportos dohányzás leszoktatás tevékenység végzésére befogadott többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerződések megkötésének legkorábbi időpontja 2015. január 1-je, így ezeknek a szerződéseknek a megkötése a beszámolási időszakot nem érintette.

A vonatkozó jogszabály-módosítás értelmében 2014. január 1-jét követően a korábbi ún. „prioritásalapú" (az egészségügyért felelő miniszter által közzétett szakmai prioritáslistán alapuló) többletkapacitás-befogadási eljárás megszűnt. További változás, hogy ezt követően az egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárást többletkapacitás-befogadási eljárásként nevesíti a jogszabály, amely alapjában a korábbi egyszerűsített eljárás gyakorlatát követi azzal a különbséggel, hogy a kérelmezhető többletkapacitások köre 2014. január 1. napját követően kibővült (új ellátási forma, új szakma). Új elemként jelent meg továbbá, hogy a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek, eszközök és a nagy értékű, még országosan nem elterjedt beavatkozások tekintetében azon szolgáltatók számára is lehetőség nyílt kérelmet benyújtani, akik az adott gyógyszer/eszköz/eljárás vonatkozásában már rendelkeznek finanszírozási szerződéssel (keretbővítés lehetősége).

A Többletkapacitás-befogadási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2014-ben négy alkalommal ülésezett, amelyek során *Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló* 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13-15/A §-a szerint benyújtott, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelmek kerültek elbírálásra.

A Bizottság javaslata minden esetben megküldésre került az egészségügyért felelős miniszter részére, aki – az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett – a többletkapacitások befogadását illetően döntéshozatalra jogosult. A Bizottság által elbírált és befogadásra javasolt kérelmek egy részében született miniszteri döntés.

Jelentős képalkotó diagnosztikai kapacitásbővítésre került sor 2014-ben: CT-befogadásban részesült a Péterfy Sándor Utcai Kórház, a Gróf Tisza István Kórház és a Budai Egészségközpont Kft., MRI-befogadásban részesült a Kenézy Gyula Kórház, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, az Uzsoki Utcai Kórház, a Budai Egészségközpont Kft. és a Semmelweis Egyetem, valamint PET/CT-befogadást nyert a Kaposvári Egyetem.

Továbbá befogadásra került a Terrorelhárítási Központ, mint speciális ellátotti kör részére, meghatározott szakmákban járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató.

A fentieken kívül számos egészségügyi szolgáltató nyert még befogadást ún. *-os HBCs-vel, valamint indexált OENO-val jelölt, magasabb szakmai felkészültséget igénylő ellátások végzésére, valamint kapacitásbővítés történt többek között a művese-kezelőhelyek, illetve a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek és eszközök alkalmazására jogosult intézményi kört illetően is.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

A Kt. 101 047,5 millió forintban határozta meg a háziorvosi és a háziorvosi ügyeleti ellátás 2014. évi eredeti előirányzatát. A 2014. március havi kifizetésektől kezdődően az egészségügyi alapellátás több szakterületén is végrehajtott finanszírozási díjemelések közvetett hatására az éves előirányzat 4 003,4 millió forinttal csökkent, hiszen a díjemelések az alapellátás egészét érintették nemcsak a háziorvosi ellátást. A finanszírozási díjemelések 2014. január hónaptól kezdődően visszamenőlegesen épültek be a rendszerbe.

A módosított előirányzat szinte teljes mértékben felhasználásra került. A 2014. évi módosított előirányzat – 5 996,8 millió forinttal – 6,6 százalékkal haladta meg a 2013. évi tényleges kifizetést. Ez biztosította a forrást az alábbiakban is részletezett finanszírozási díjemelésekre:

- A háziorvosi szolgálatok teljesítménydíjazásának (Ft/pont érték) emelése. Egyúttal 300 ponttal növekedett azon háziorvosi szolgálatok degressziós ponthatára, melyek háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost, valamint szakdolgozót alkalmaznak teljes munkaidőben.
  Ennek hatására a hozzávetőlegesen 200 forintos pontérték 206-210 forintos értékre emelkedett. Az emeléshez éves szinten 2 400,0 millió forint volt szükséges.

- A háziorvosi indikátorrendszer díjazásának növekedése. Az eddigi 3 000,0 millió forintos éves díjazás kerete 60,0 százalékkal emelkedett, így 2014-ben már 4 800,0 millió forint (400 millió forint/hó) állt rendelkezésre az indikátorrendszerben elért eredmények díjazására. A praxisban folyó szakmai és minőségi munka díjazására 1 800,0 millió forinttal több kifizetés történt.

- Szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetése. Új elemként jelent meg a háziorvosi szolgálatok finanszírozásában, melynek értelmében, a szolgálatokban – legalább heti 20 órás munkaidőben – alkalmazott szakdolgozóként meghatározott összegű (10-20 000 forint/hó) díjazásra jogosult a háziorvosi szolgáltató. Ezen intézkedés végrehajtása 1 800,0 millió forint plusz forrás bevonását igényelte.

Az előirányzat felhasználása jogcímenként és az előző évhez képest a következőképpen alakult:

Jogcím	2013. évi kifizetés (MFt-ban)	2013. évi részarány (%)	2014. évi kifizetés (MFt-ban)	2014. évi részarány (%)
Fix összegű díjazás	20 669,8	22,7	20 929,4	21,6
Területi kieg. díjazás	2 583,6	2,8	2 589,1	2,7
Eseti ellátás díjazása	625,6	0,7	597,2	0,6
Teljesítmény díjazása	57 066,8	62,7	62 789,8	64,7
Ügyeleti szolgálat	10 100,7	11,1	10 137,7	10,4
Összesen	**91 046,5**	**100**	**97 043,2**	**100,0**

A háziorvosi szolgálatok által végzett minőségi és hatékony tevékenységek ösztönzése érdekében 2010-ben bevezetett háziorvosi indikátorrendszerben az alábbi változások történtek 2014-ben:

- 2014. januártól az indikátorrendszer alapján kifizetett díjazás mértéke a korábbi 250,0 millió forint/hó összegről 400,0 millió forint/hó összegre emelkedett. Ez azt jelentette – figyelembe véve az orvosok gyógyszerrendelésének értékeléseit mérő indikátorokra vonatkozó negyedéves kifizetést –, hogy egy adott negyedév első 2 hónapjában 320,0-320,0 millió forint, míg utolsó hónapjában 560,0 millió forint kerülhet kifizetésre.
- 2014. januártól a négy gyógyszer indikátor esetében új gyógyszer-célérték került kihirdetésre, mely 2014. márciustól került alkalmazásra.
- 2014. áprilistól bevezetésre került egy új, a COPD-s betegek gondozását mérő indikátor. Ezzel a felnőtt indikátorok száma 16-ra emelkedett, a 8 gyermek indikátor értéke a korábbi 1,875 pontról 2 pontra nőtt.
- 2014. júliustól a négy gyógyszer indikátor esetében újabb gyógyszer-célérték került kihirdetésre, melyet a 2014. szeptembertől került alkalmazásra.
- 2014. szeptembertől módosult az indikátorrendszer szakmai indikátorainak szabályozása, mely alapján a korábban bevezetett COPD indikátor célcsoport meghatározása egy további OENO kóddal bővült.

A nem bejelentkezett biztosítottak eseti ellátásának díjazására 597,2 millió forint kifizetés történt. Ez kevesebb, mint az előző évben kifizetett összeg, mivel az eseti ellátások száma 2014-ben alacsonyabb volt az előző évhez képest.

Az online jogviszony ellenőrzésekre 2014-ben 2 681,1 millió forint kifizetés történt, amely alig kevesebb az előző évben ugyanezen a jogcímen kifizetett összegnél.

A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében az egy szolgálatra jutó 2014. évi összes finanszírozás átlagos összege (eszköz – és ingatlantámogatással) 13,2 millió forint volt, mely 1,1 millió forint havi átlagbevételt eredményezett. Ez azt jelenti, hogy a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében a finanszírozás 5,3 százalékkal emelkedett a 2013-as évhez képest. A területi ellátási kötelezettséget nem vállaló praxisok átlagos díjazása éves szinten 5,6 millió forint volt, mely havi 477,5 ezer forintot jelentett, azaz szintén jelentős mértékben emelkedett a tavalyi évhez képest a finanszírozás. Az emelkedés okaként a teljesítményarányos díjazás (forint/pont) érték növelése, a szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetése nevezhető meg, valamint a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgálatok esetében a háziorvosi indikátorrendszer díjazásának növelése.

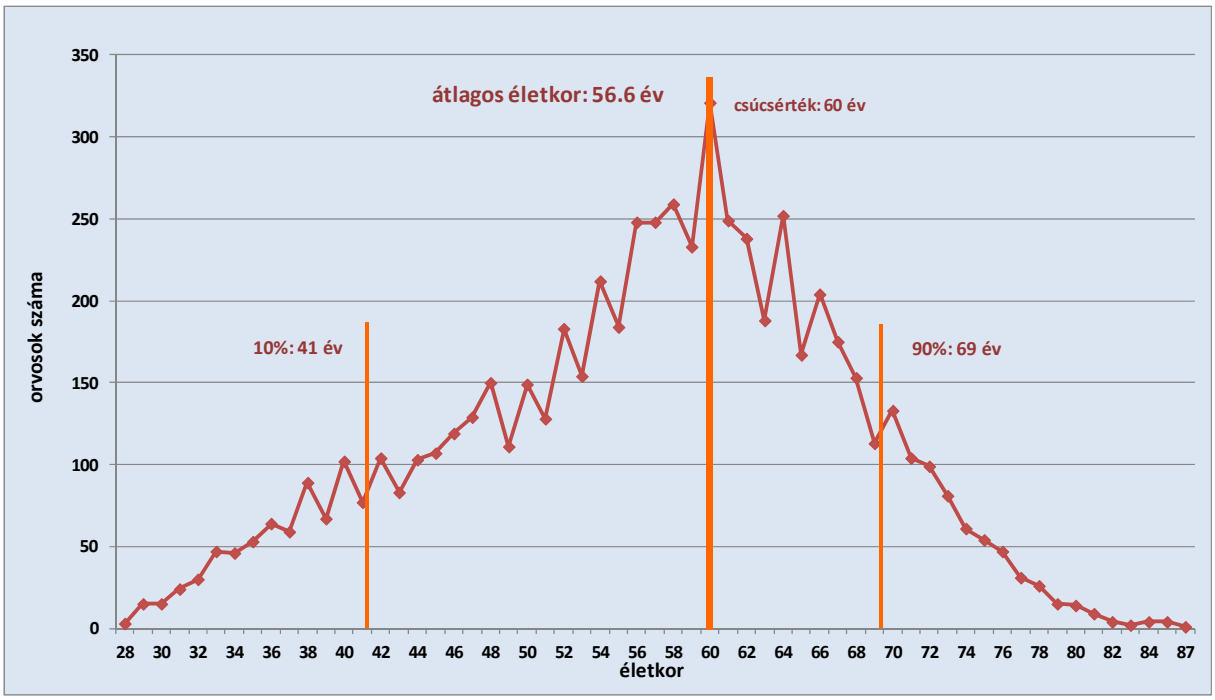
A települési önkormányzatok 2014. évben 5 új körzetet létesítettek, ugyanakkor 12 körzet megszűnt. Területi ellátási kötelezettség nélkül nem létesült új szolgálat, ezzel szemben 12 ilyen típusú szolgálat megszűnt.

Az előző évekhez hasonlóan viszonylag kevés új körzet került kialakításra és egyre nagyobb számban előfordul a kisebb ellátandó lakosságszámmal bíró, egymás mellett található körzetek összevonása.

Az elmúlt év folyamán átlagosan 6 641 háziorvosi szolgálat, decemberben 6 629 szolgálat finanszírozására volt érvényes szerződése az OEP-nek. A finanszírozott praxisok 95,9 százaléka területi ellátási kötelezettséggel, 4,1 százaléka területi ellátási kötelezettség nélkül működött. A praxisok 54,0 százaléka a felnőtt korúak, 23,3 százaléka gyermekek ellátását biztosította, 22,7 százaléka pedig vegyes típusú szolgálatként működött.

A vállalkozási formában működtetett háziorvosi szolgálatok száma 2014. decemberben 6 215 volt, amely az összes finanszírozott praxis 93,8 százalékát teszi ki, ez megegyezik az előző évi értékkel.

A betöltetlen körzetek száma 2014. decemberben 271 volt, ebből az egy éven túl betöltetlen praxisok száma 171.



Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, amelyekben a területi ellátási kötelezettségnek egy évet meghaladóan csak helyettesítéssel tudtak eleget tenni 2006. január 1-jétől, az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos igénybevételével is történhet feladatellátás.

A 2014-es évben az OALI közreműködésével 7 háziorvosi szolgálat került betöltésre, 7 szolgálat működtetését pedig visszaadta az ellátásért felelős önkormányzatoknak. Így hasonlóan a tavalyi évhez, decemberben 26 szolgálatot működtetett az OALI. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott körzetek finanszírozása 60,0 százalékra csökkentett fix összegű és területi kiegészítő díjazással történt.

Az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott a hajléktalanok háziorvosi ellátását biztosító szolgálatok száma: 2014. decemberben összesen 13 hajléktalanokat ellátó háziorvosi szolgálat, 10 hajléktalan centrum és hozzájuk tartozó mozgó szakorvosi szolgálat működött országosan. Fix összegű díjazásukra – éves szinten – összesen 1 370,6 millió forint került kifizetésre, ami a 2013-as kifizetéshez képest 18,5 százalékos növekedést jelent. Ennek oka egyrészt a 2014. évi tárgyévi előirányzat növekedése, másrészt a 2013. évi átlagos finanszírozási díjak emelkedése.

A háziorvosi ügyeleti ellátás díjazására 2014. évben 10 137,7 millió forint kifizetés történt, mely kismértékben meghaladja az előző évi finanszírozási összeget. A központi ügyeleti szolgáltatók száma 2014. december hónapban 233 volt, az általuk ellátott lakosságszám meghaladta a 9,8 millió főt. Ez azt jelenti, hogy az ország lakosságának kb. 97,5 százaléka központi ügyeleti ellátás keretein belül veheti igénybe a sürgősségi ellátás e szintjét.

Védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

2014-ben a védőnői szolgálatok, valamint az anya-, gyermek- és ifjúságvédelem törvényi előirányzata 20 698,2 millió forint volt, a teljesítés 22 472,7 millió forint, év közben az előirányzatra 1 774,6 millió forint összegben átcsoportosítás történt.

Az *iskola-egészségügyi ellátás* 2014. évi 2 217,1 millió forintos eredeti előirányzata év végére 2 241,6 millió forintra növekedett. Az emelkedésre a 2014. évi maradvány felosztáskor a teljes-munkaidős iskolaorvosi szolgáltatók részére meghatározott összegek kifizetésére tekintettel került sor.

Az iskola-egészségügyi ellátás normatív rendszerben történő finanszírozása keretében 632,7 millió forint kifizetés történt, amely 1,8 százalékkal kevesebb az előző évi adatokhoz viszonyítva.

A Kr. 20. § (3) bekezdése alapján a díjazás alapjául szolgáló havi fejkvóta összege 47,8 forint. A normatív rendszerben finanszírozott szolgálatok száma 2014. december hónapban 3 046, amelyből betöltetlen 145, az ellátandó létszám pedig 1 099 618 fő volt.
Az iskola-egészségügyi ellátás keretén belül a főállású iskolaorvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok finanszírozására 1 608,9 millió forint kifizetés történt. A teljes munkaidős iskolaorvosi szolgálatok az év végi kasszamaradvány felosztásakor szolgálatonként 105 ezer forint kifizetésben részesültek. Tartós helyettesítés miatt 27 szolgálat kapott csökkentett finanszírozást, ami másfélszeres szolgálatszámot jelent az előző évhez viszonyítva.
Főállású iskolaorvossal működő szolgálatok száma év végén 237, a betöltetlen szolgálatok száma 55. A főállású iskolaorvosi szolgálatok által ellátandó létszám: 437 170 fő volt.

December hónapban 4 016 területi védőnői szolgálatot (1 944 területi és 2 072 vegyes körzet), valamint 1 039 iskolavédőnői szolgálatot finanszírozott az OEP. A védőnői szolgálatok száma az előző év december havi adataihoz viszonyítva a területi védőnők esetében 1,0 százalékos növekedést mutatott, míg és az iskolavédőnőknél mindössze 1 szolgálattal lett több, ami százalékos változást nem jelent. A területi védőnői szolgálatok által ellátott gondozottak és iskolások száma 1 042 771 fő, az iskola védőnői szolgálatok által ellátottak száma 879 602 fő volt. Egy körzeti védőnői szolgálatra átlagosan 260 fő gondozott, egy iskola védőnői szolgálatra pedig 847 fő gondozott jutott. December hónapban 354 betöltetlen szolgálatra (315 területi + 39 iskolavédőnői) volt finanszírozási szerződés, tartós helyettesítés miatt 258 területi védőnői szolgálat és 25 iskolavédőnői szolgálat részesült csökkentett finanszírozásban.

2014-ben a védőnői ellátás fix összegű és az ellátandók létszáma alapján járó díjazására 19 526,9 millió forint került kifizetésre, ez 9,8 százalékkal magasabb kifizetést jelent az előző évi adatokhoz képest.

Ennek oka, hogy a védőnői ellátásra fordítható finanszírozási keret közel 10 százalékkal növekedett 2014-ben. A március havi utalványozás során a szolgálatok egyszeri díjkifizetésben részesültek, a 2014. január-február hónapokra járó díjkülönbözet alapján.
A területi védőnői szolgálatok több település ellátásáért kiegészítő díjazásban részesülnek, melynek 2014. évi összege 203,3 millió forint volt.

Az anya-, gyermek- és csecsemővédelmi előirányzat terhére az anyatejgyűjtő állomások és a speciális gyermek-egészségügyi ellátás finanszírozása valósult meg.

E feladatok finanszírozására éves szinten 486,3 millió forint kifizetés történt, melyből az anyatejgyűjtő állomások finanszírozása 307,9 millió forint volt, míg a speciális gyermek-egészségügyi feladatokra 178,4 millió forint jutott. A kassza kiadása 2 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Ennek oka, hogy változott a speciális gyermek-egészségügyi ellátásban részesülő gondozottak létszáma, ami díjnövekedést eredményezett.

A 2014-es évben 57 gyermekgyógyászati és 49 nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat működött. A szolgáltatók finanszírozásának alapja a jelentett esetszám; a gyermekgyógyászati MSZSZ-ek éves jelentett esetszáma 50 726, az éves korrekciós esetszám pedig 542 volt, míg a nőgyógyászati MSZSZ szolgáltatók korrekcióval módosított éves esetszáma: 32 993.

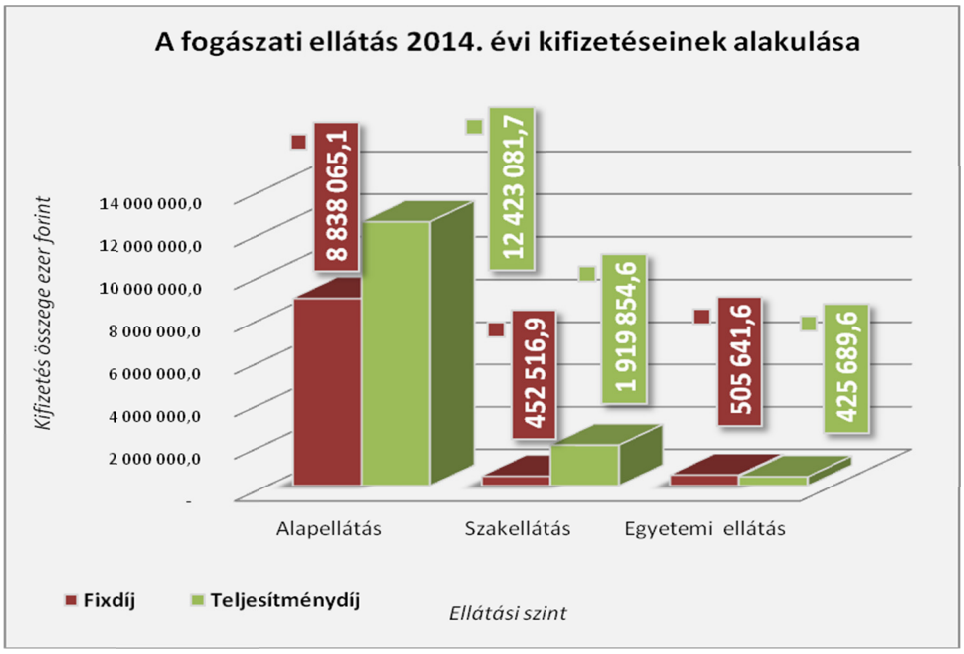
A Mozgó Szakorvosi Szolgálatok működtetésére összesen 217,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a gyermekgyógyászati szolgálatok 121,6 millió forintban, szolgálatonként havonta átlag 177,8 ezer forintban, míg a nőgyógyászati szolgálatok 96,3 millió forintban, átlag havi 163,8 ezer forintban részesültek. Gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatoknál az egy esetre jutó kifizetés átlag 2,4 ezer forint, míg nőgyógyászati ellátás esetén 2,9 ezer forint volt.

Fogászati ellátás

A fogászati ellátás finanszírozására a Kt. 24 446,8 millió forint összegű előirányzatot határozott meg. A prevenciós fogászati beavatkozások pontértékének emelése és új kiegészítő díj bevezetése következtében 26 241,7 millió forintra emelkedett az éves előirányzat, amely teljes mértékben kifizetésre került.
A pontemelés eredményeként megnövekedett teljesítménydíj és a kiegészítő díj 2014. január hónaptól kezdődően, visszamenőlegesen épült be a finanszírozási rendszerbe.

Az éves teljesítés az előző évi kiadáshoz viszonyítva 7,3 százalékkal magasabb. A teljesített kifizetés megoszlása: alapellátás 87,2 százalék, szakellátás 9,2 százalék, egyetemi szakellátás pedig 3,6 százalék.

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 százalékkal, az egyetemi szakellátásnál 0,1 százalékkal emelkedett, a szakellátás 0,6 százalékkal csökkent. A kifizetés 39,9 százaléka fix összegű, 60,1 százaléka teljesítményarányos díjazásra szolgált.



Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2 810 (összesen heti 76 545 óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10 436 óra kapacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti rendelési ideje 2 600 óra volt. Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 százalékkal emelkedett, a heti rendelési idő nem változott.

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz képest.

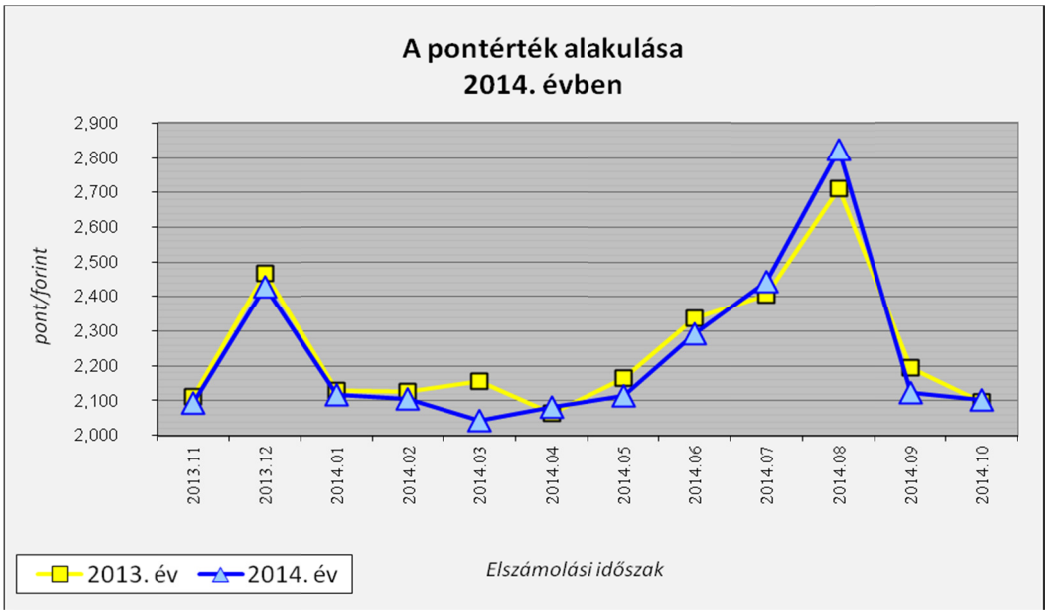
Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés, a szolgálatok száma 5,9 százalékkal, a heti rendelési idő 6,2 százalékkal lett magasabb. A vegyes típusú szolgálatoknál minimális kapacitás-emelkedés történt, a heti rendelési idő azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola-ifjúsági és a felnőtt szolgálatok esetében. Az iskola-ifjúsági szolgálatok száma 1,2 százalékkal, a felnőtt szolgálatok száma 0,4 százalékkal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem változott, a heti rendelési idő 0,3 százalékkal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás kapacitásadataiban nem volt változás.

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 százalékkal, a heti rendelési idő 1,1 százalékkal.

Jelentős kapacitás-növekedés történt a szájsebészeti szakrendelések esetében, amelyek száma 4,6 százalékkal, a heti rendelési idő 3,2 százalékkal emelkedett. A fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti rendelési idő között ellentétes irányú változás történt. A fogszabályozási szakrendelések száma 0,6 százalékkal csökkent, míg a heti rendelési idő kis mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 százalékos emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 százalékkal csökkent. A parodontológiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt.

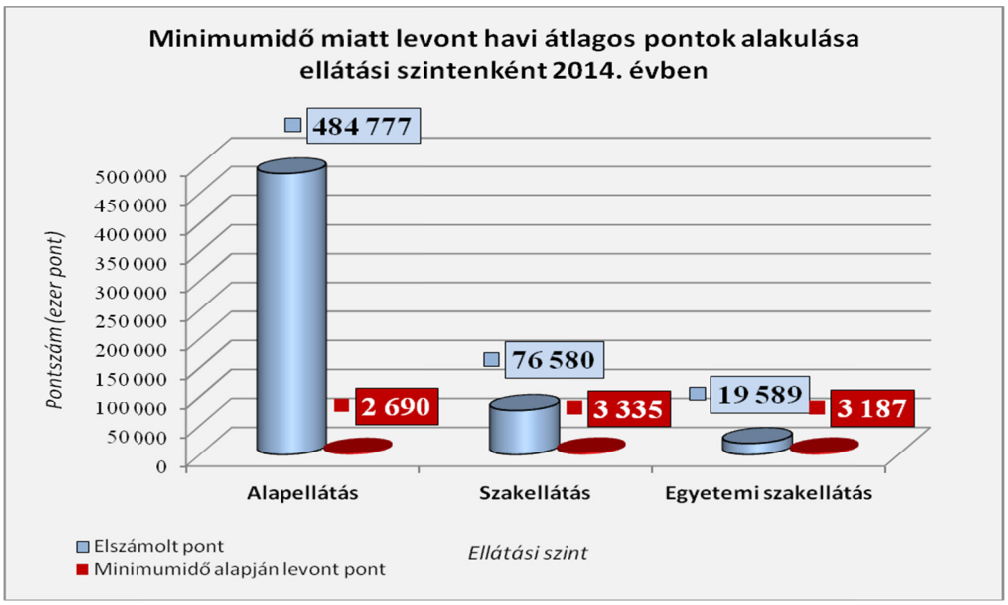
Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a szakrendelések száma 7,4 százalékkal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A fogyatékkal élő gyermekek szakellátását végző szakrendelések száma 6,3 százalékkal, a heti rendelés idő 6,2 százalékkal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 százalékkal csökkent.

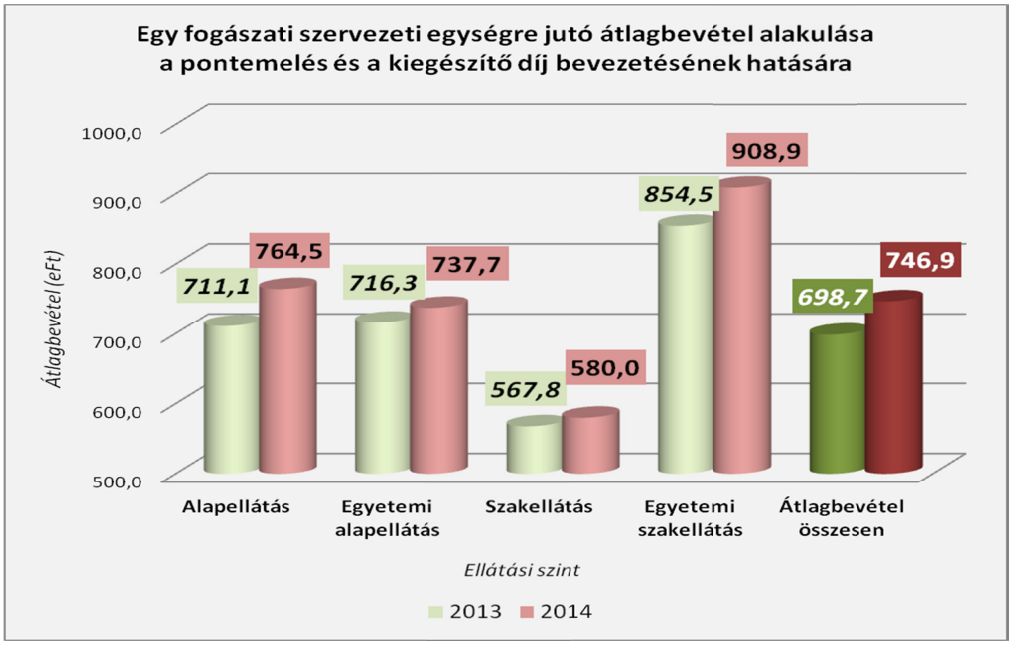


A pontérték alakulása – figyelembe véve a szezonális ingadozást – kiegyensúlyozott képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 százalékkal nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 százalékkal, a szakellátásban 6,9 százalékkal emelkedett. Jelentős emelkedés történt az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 százalékkal magasabb.

A Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 százaléka került levonásra. A levont pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 százalék, szakellátásban 4,4 százalék, egyetemi szakellátás 16,3 százalék. Az előző évhez viszonyítva 27,9 százalékkal emelkedett a levonásra került pontszámok száma.



Az egy szolgálatra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez viszonyítva 6,9 százalékkal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj bevezetése, a prevenció és gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások pontértékeinek emelkedése, továbbá a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 2014. évi maradványának felosztása eredményezte.



Nagyobb arányú, 7,5 százalékos átlagbevétel-emelkedés az alapellátásban történt. Ennek oka, hogy a prevenciós beavatkozások elvégzésére döntő többségében az alapellátás szintjén kerül sor. Hozzájárul a bevétel emelkedéséhez a fogászati alapellátást nyújtó szolgálatokat megillető kiegészítő díj is. Az átlagbevétel a szakellátásban 2,1 százalékkal, az egyetemi szakellátásban 6,4 százalékkal magasabb. A fogászati finanszírozásban bekövetkezett módosítások hatására egy fogászati szervezeti egységre jutó átlagbevétel 6,9 százalékos növekedést mutat.

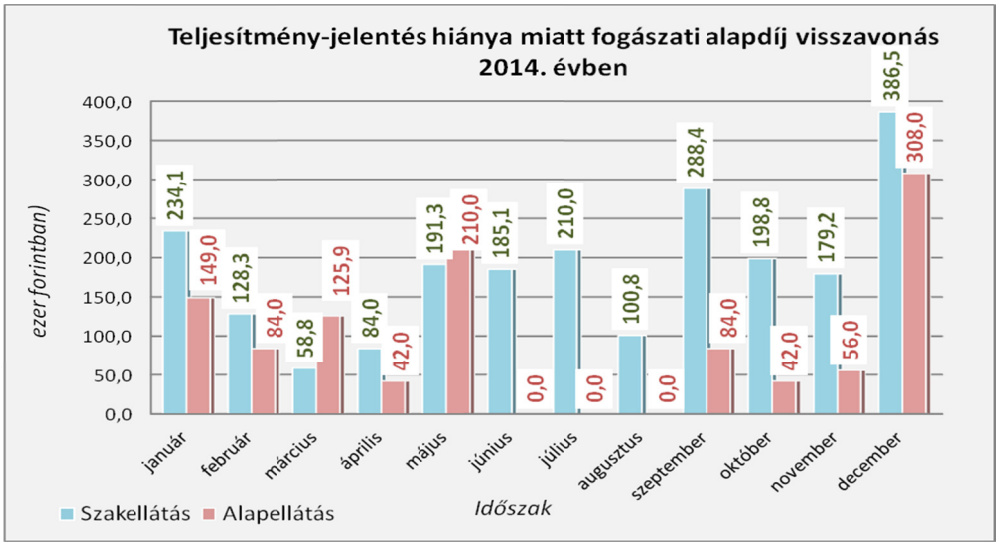
Az alapellátás keretében ellátási típusonként eltérő mértékben emelkedett az átlagbevétel. A legnagyobb mértékű emelkedés az ügyeleti és iskolai, ifjúsági szolgálatok esetében történt, az ügyeleti szolgálatok átlagbevétele 17,4 százalékkal, az iskolai, ifjúsági szolgálatok száma 14,3 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A vegyes szolgálatok átlagbevétele 7,9 százalékos, a gyermek szolgálatok átlagbevétele ettől magasabb mértékű, 8,7 százalékos emelkedést mutat. Az egyetemi szolgálatok átlagbevétele 3,0 százalékkal nőtt. A felnőtt szolgálatok esetében 1,8 százalékos átlagbevétel emelkedést történt.

A szakellátás keretében a legnagyobb mértékű bevétel-emelkedés a gyermek szakellátás esetében történt, az átlagbevétel 24,6 százalékkal nőtt.
Jelentős mértékben emelkedett a szájsebészeti és az egyetemi szakrendelések átlagbevétele, szájsebészeti szakrendelések esetén 8,2 százalékos, az egyetemi szakellátás esetén 6,4 százalékos emelkedés mutatható ki. A röntgen szakellátásban kisebb mértékű 3,1 százalékos bevétel-növekedés volt.

Nagyobb mértékben csökkent a parodontológiai szakrendelések bevétele, 9,8 százalékkal alacsonyabb az előző évhez képest. A fogszabályozási és a fogyatékkal élő felnőttek szakellátását biztosító szakrendelések esetében kisebb mértékű bevétel-csökkenés történt. A fogyatékkal élő gyermek szakellátása esetén 1,3 százalékkal emelkedett az átlagbevétel.

A Kr. 22. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a területi ellátási kötelezettség nélkül működő fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató (ideértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatót is) abban az esetben jogosult alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat/szakrendelés ellátást nyújtott. Ha adott fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhónapra vonatkozóan teljesítményt-jelentést nem adott le, akkor a kifizetett alapdíj visszavonásra került.

Éves szinten a visszavonás 67 szolgáltató 69 szervezeti egységét érintette, összesen 3 346,2 ezer forint alapdíj visszavonására került sor. A visszavonás megoszlása: alapellátás 32,9 százalék, szakellátás 67,1 százalék.



Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6 046,9 millió forintot irányzott elő. Az év folyamán – július hónapban – sor került az előirányzat 150,0 millió forinttal történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal azonos összeg, összesen 6 196,9 millió forint került kifizetésre, mely összeg az előző évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg 6 117,6 millió forint volt, mely 112,0 millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.
Az egy km-re jutó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 százalékkal több, mint a 2013. évi adat).

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszírozta a Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6-tal (7,3 százalékkal) csökkent, az aktív gépjárműveik száma 3-mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik száma 25-tel (3,6 százalékkal) nőtt az előző évhez képest.

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került kiutalásra, ami 12,0 millió forinttal (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 esettel (14,4 százalékkal) volt több, így összesen 7 357 esetet – ebből közigazgatási határon belüli szállításként 3 188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 4 169 esetet – finanszírozott az OEP.

Az egy halottszállítási esetért járó költségtérítés összege a 2013-as évhez képest nem változott. A közigazgatási határon belüli szállítás esetén 8 400 forint, a közigazgatási határon kívüli szállítás esetén 12 600 forint illeti meg szolgáltatókat. A 2014-es évben a 66 kórboncolási célból végzett halottszállításra finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató közül 53 szolgáltató jelentett halottszállítási teljesítményt, 8-cal (16,0 százalékkal) kevesebb, mint 2013-ban. A rendelkezésre álló, havonta meghatározott keretösszegből a halottszállítás költségtérítése után a fennmaradó összeg került felosztásra a betegszállító szolgáltatók között, a teljesítményük arányában.

Művesekezelés

Az E. Alap 2014. évi költségvetésében a dialízis kezelések finanszírozására 23 171,1 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, amely teljes egészében kifizetésre került. A művesekezelés finanszírozásában jelentős változások az előző évhez képest nem történtek.

A 2014. év végi állapot szerint 17 szolgáltatónak 1 208 kezelőhellyel 69 állomásra volt érvényes finanszírozási szerződése. A dialízis szolgáltatók részére összesen 857 075 dialízis kezelés került elszámolásra.

Elszámolt kezelésszámok, kezelési típusonként

Kezelés típusok	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2014/2013. év
	Kezelés szám	Kezelés szám	Kezelés szám	Kezelés szám	Kezelés szám változás
Akut haemodialízis	8 597	8 914	6 751	5 941	88,00%
Krónikus haemodialízis	315 157	287 762	231 109	214 840	92,96%
Haemofiltráció	3 812	4 054	4 305	3 875	90,01%
High flux kezelés	154 672	185 841	225 205	238 035	105,70%
Haemodiafiltráció (on-line)	350 334	357 859	380 378	394 352	103,67%
Haemoperfuzio	53	37	52	32	61,54%
Összesen:	832 625	844 467	847 800	857 075	101,09%
CAPD kezelés*	305 453	321 791	318 016	310 468	97,63%

Októberben 5 874 fő krónikusan dializált beteg volt, a CAPD-vel (folyamatos ambuláns peritoneális dialízis) kezeltek száma 887 fő, az EPO (eritropoietin) kezelésben részesülő predializált betegek száma pedig 3 774 fő volt. Az előző év azonos időszakához képest minimális betegszám-növekedés tapasztalható a krónikus dializált betegek számában (100,5 százalék), míg a CAPD-vel kezeltek és az EPO kezelésben részesülő betegek számában csökkenés figyelhető meg (96,6 százalék, illetve 96,1 százalék).

Az egy művesekezelésre jutó alapdíj összege átlagosan 61 forinttal, azaz 0,28 százalékkal csökkent az előző finanszírozási évi átlaghoz viszonyítva, ugyanezen időszakban az esetszám átlagosan 2,0 százalékkal csökkent.

A predializált betegek EPO kezelése vonatkozásában az alapdíj összege átlagosan 946 forinttal, azaz 3,6 százalékkal nőtt az előző finanszírozási évi átlaghoz viszonyítva.

Otthoni szakápolás jogcím

A Kt. a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni ellátások finanszírozására 4 479,8 millió forintot irányzott elő a 2014-es évben, a teljesítés összege 4 440,0 millió forint volt, 3,8 százalékkal több, mint az előző évben.

Otthoni szakápolás

Az otthoni szakápolásra 3 379,6 millió forint kereten felül az elmúlt években pályázati úton befogadott szolgáltatók finanszírozására 172,2 millió forint állt rendelkezésre. A 2014-ben befogadásra kerülő új pályázatos szerződések fedezetére további 100,0 millió forint állt rendelkezésre.

A teljesítmény-díjazásra kifizetett 3 555,2 millió forint összegen felül kifizetésre került 153,0 millió forint területi pótlék.

Ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összeg 2,6 millió forint volt.

Az otthoni szakápolás keretében a rehabilitációs tevékenységekre 1 510,0 millió forint került kifizetésre.

Otthoni szakápolásban 71 108 eset keretében 54 462 beteg ellátása történt meg. A betegek átlag 23,07 napot töltöttek az ellátásban, átlag 68 088 forint költséggel.

Az otthoni szakápolás 2014. évi kapacitás kihasználtsága 99,1 százalék volt.

Az ellátási forma finanszírozási egysége a vizit, alapdíja 2014-ben nem változott, összege 3 380 forint.

Az európai uniós támogatási konstrukcióban (TIOP, ROP) befogadott szolgáltatók közül 2014-ben újabb 1 szolgáltatóval történt szerződéskötés. A TIOP, ROP pályázati formában befogadott szolgáltatók részére rendelkezésére elkülönített kapacitások kihasználtsága 44,4 százalék volt.

Otthoni hospice ellátás

Az otthoni hospice ellátás 828,0 millió forint keretén felül az elmúlt években pályázati úton befogadott szolgáltatók finanszírozására 172,2 millió forint került elkülönítésre a szakápolási előirányzaton.

A teljesítménydíjazásra 697,2 millió forint, míg területi pótlék címen 34,5 millió forint összeg került kifizetésre.

Az ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összege 1,9 millió forint volt.

Az otthoni hospice ellátás 2014. évi kapacitás kihasználtsága 83,7 százalékos volt.

Az ellátási forma finanszírozási egysége az ellátási nap, alapdíja 2014-ben nem változott, a vizitdíj összegének 120 százaléka, 4 056 forint.

Otthoni hospice ellátásban 6 169 eset keretében 5 601 beteg ellátása történt meg. A betegek átlag 30,05 napot töltöttek az ellátásban, átlag 130 981 forint költséggel.

Az európai uniós támogatási konstrukció (TIOP, ROP) keretében nem történt befogadás a hospice ellátásba a 2014-es év során. A TIOP, ROP pályázati formában korábban befogadott szolgáltatók részére, az otthoni szakápolás keretében elkülönített kapacitások kihasználtsága 44,4 százalék volt.

Célelőirányzatok

<u>Méltányossági alapon történő térítések</u>

Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés *a)* pontja alapján az egészségbiztosító – az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja.

A Kt. 21.§-a alapján a természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5 611,3 millió forint használható fel. A kifizetés előirányzati szinten teljesült.

Az engedélyezés egyedi, különleges kezelési eljárást igénylő esetekben indokolt. Orvosszakmai megalapozottság esetén a rendelkezésre álló fedezet figyelembe vételével kerül sor az elbírálásra. Több azonos tárgyú kérelem benyújtása esetén az egészségbiztosító egységes elbírálási feltételrendszert dolgoz ki, független szakmai tanácsadó testület felállításával, és a döntéshozatalba bevonásával. Egyidejűleg

annak a lehetőségét is megvizsgálja, hogy az adott eljárás közfinanszírozásba való befogadásához milyen szakmai, jogszabályi, finanszírozási, fedezeti és egyéb feltételek szükségesek.

Közfinanszírozásba történő befogadás

Súlyos gerincferdüléses scoliosis és gerincdaganat nagy értékű műtéte
A szakmai feltételek megteremtésével lehetőség nyílt arra, hogy az addig külföldön végzett, kiemelten költséges gerincműtéteket hazai ellátással váltsa ki az egészségbiztosító. Azon betegeket, akiknek a súlyos gerinc-deformitása az életminőséget jelentős mértékben rontja (pl. légzési nehézséget okoz), vagy daganatos gerincbetegség miatt szükséges a műtéti kezelése, méltányossági finanszírozással sikerült hazai ellátásban részesíteni, és ezzel a kapcsolódó a várólistát is sikerült csökkenteni. Mindeközben az egészségbiztosító kidolgozta az eljárások közfinanszírozásának módszertanát és 2014-ben a nagy értékű műtéti eljárás közfinanszírozás keretében országosan elérhetővé vált a rászoruló betegnek. Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról rendelkező 4/2014. (I.20.) EMMI rendelet 5. számú mellékletének 14. pontja értelmében 2014. január 21. napjától közfinanszírozásba befogadásra került a súlyos gerincelváltozások esetén alkalmazott műtéti technika.

Tartós, invazív otthoni lélegeztetési program
Különböző légzésbénulásos megbetegedések esetén, amennyiben orvosszakmai és szociális szempontból a beteg az otthonában is ápolható, az OEP a lélegeztető gép havi bérleti díját méltányosságból átvállalta. Több, mint öt éves szakmai tapasztalatgyűjtés után a kezelés a közfinanszírozásba befogadásba került. A Kr. 8. számú melléklete alapján az otthoni tartós gépi lélegeztetés 2014. január 1. napjától közfinanszírozásba befogadásra került 00025 kódon, „Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása” megnevezéssel 3,8-as szorzóval.

Egyedi méltányosság alapján finanszírozott új eljárások
Az általános közfinanszírozásba átkerült eljárások helyett 2014. április hónaptól a krónikus hepatitisz C vírusfertőzések korszerű és eredményesebb, interferon nélküli kezelésének, továbbá 2014. június hónaptól a rosszindulatú prosztatadaganatban szenvedő betegek csontáttéteinek Rádium-223-dikloriddal történő kezelésének egyedi méltányosságból történő finanszírozása kezdődött el.

Egyedi méltányosság alapján finanszírozott eljárások

A rendelkezésre álló 5 611,3 millió forint összegű fedezet teljes egészében felhasználásra került. Döntő részét (4 732,2 millió forint) 2014-ben – az előre meghatározottak szerint – a ritka tárolási betegségben szenvedő betegek kezelésére fordította az egészségbiztosító. A beérkezett összesen 678 db méltányossági kérelemből pozitív elbírálás alapján 333 beteg kezelésének finanszírozására került

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet tette korábban lehetővé a szolgáltatók részére történő eszköz- és ingatlantámogatás biztosítását. Ezen a jogcímen 2014. évben 60,6 millió forint kifizetés történt, ami 10,2 millió forinttal kevesebb az előző évi kifizetésnél.

A *Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról* szóló 2006. évi CXXI. törvény 32. §-a értelmében a korábbi Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak által a 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az alapellátási vállalkozások támogatására kötött „Szerződés-kiegészítések"-nek az alap- és kiegészítő támogatások folyósítására vonatkozó részei 2007. január 1-jei hatállyal megszűntek, így ettől az időponttól alap-és kiegészítő támogatás folyósítására nem került sor. A továbbiakban csak hitelintézeti kölcsöntámogatás folyósítható a hitelszerződések futamidejének lejártáig.

A futamidő lejártából adódóan a támogatási szerződések száma és a finanszírozás összege 2014. évben tovább csökkent. A havi támogatás összege decemberben 4,8 millió forint volt. A szerződéskötésre jogosult háziorvosi szolgáltatók közül 0,1 százalék rendelkezett még eszköztámogatási szerződéssel (4 szolgáltató), míg ingatlantámogatási szerződéssel 2,6 százaléka (155 szolgáltató).

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet újra lehetővé tette, hogy az alapellátási (vállalkozási formában működő) szolgáltatók az eszközpótláshoz, a meglévő eszközpark fejlesztéséhez, korszerű eszközpark létrehozásához támogatást vegyenek igénybe.

A támogatási összeget (havi 50 000 forint, max. összesen: 1 500 000 forint értékben) 2011. októbertől 2012. május 31-ig igényelhették a vállalkozási formában működő szolgáltatók.

A 2014. január 1-november 30. közötti időszakban összesen 1 602,2 millió forint került kifizetésre ezen a jogcímen a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi valamint az iskola-egészségügyi szolgáltatók részére.

2014-ben az alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj előirányzata 3160,8 millió forint volt, a fenti két jogszabály alapján kifizetés összesen 1 662,8 millió forint összegben történt.

Tartósan betöltetlen körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének támogatása

A Kr. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására az OEP 2014. augusztus 1-jén pályázatot írt ki. Pályázatot az az orvos nyújthatott be, aki *A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről* szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

Összesen 46 pályázat érkezett az OEP-hez. Ezeket első körben egy bontási bizottság tekintette át és ellenőrizte formai szempontból. A bírálóbizottság elé 45 pályázat kerülhetett, mivel egy pályázatából hiányzott az illetékes önkormányzat támogató nyilatkozata, melyet a hiánypótlásra való felszólítás után sem pótolt.
A 45 pályázatból 41 kapott nyertes minősítést.

A 41 nyertes pályázóból végül 38 háziorvossal került megkötésre finanszírozási és támogatási szerződés, így az összes kifizetésre kerülő támogatási összeg 412,8 millió forint lett.

Mentés

A mentés finanszírozására szolgáló költségvetési előirányzat 2014. évben 28 738,3 millió forint volt, mely összeg július hónapban 500,0 millió forinttal megemelésre került. A mentés finanszírozására így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal azonos összeg, összesen 29 238,3 millió forint került kifizetésre, 3 237,9 millió forinttal (12,5 százalékkal) több, mint az előző évben.

A beszámolással érintett időszakban a mentés kassza terhére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. mentési tevékenységét, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szervátültetéssel kapcsolatban végzett szállítási feladatait finanszírozta az OEP.

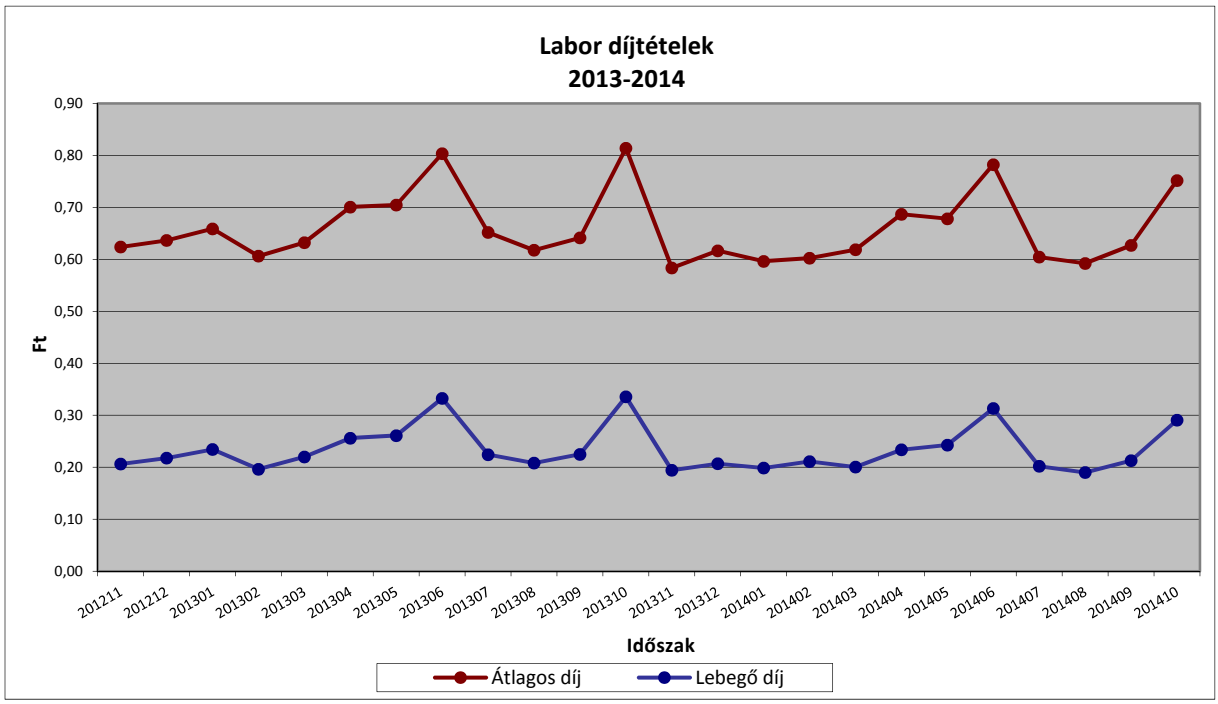
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. és az OVSZ finanszírozási díja az előző évhez képest nem változott. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. havi 61,0 millió forint fix összegű díjazásban, éves szinten 732,0 millió forintban részesült, míg az OVSZ szervszállítási feladatait havi 4,0 millió forint fix összeggel, az év folyamán összesen 48,0 millió forinttal finanszírozta az OEP. A mentés kassza fennmaradó része, összesen 28 458,3 millió forint az OMSZ részére került kifizetésre.

Laboratóriumi ellátás

A laboratóriumi ellátás 2014. évi törvényi előirányzata 21 118,5 millió forintban került meghatározásra, év végén az előirányzatról 52,0 millió forint átcsoportosítás történt, a teljesítés 21 066,5 millió forint volt.

A laboratóriumi ellátás finanszírozását befolyásoló jelentős jogszabályi változás 2014-ben nem volt, a TVK-t továbbra is alkalmazni kellett: a labor finanszírozás szabályának értelmében a teljesítmények TVK feletti része lebegő pont-forint értékkel kerül elszámolásra. Az alapdíj 2014-ban a járóbeteg-szakellátás forint -/ pont értékével volt megegyező: 1,50 forint.

A laboratóriumi díjtételek alakulásának tendenciáját mutatja be az alábbi diagram a 2013-2014. finanszírozási év vonatkozásában.



A finanszírozás főbb paramétereinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés		2013. év	2014. év	Változás 2013-ról 2014-re
Beavatkozások száma		152 665 098	174 160 223	114,1%
Esetszám		13 745 022	15 357 645	111,7%
Egy esetre jutó beavatkozás		11,11	11,34	102,1%
Pont		31 154 779 148	35 652 751 774	114,4%
Egy esetre jutó pont		2 267	2 321	102,4%
Átlagos heti rendelési óra	**szakorvosi**	10 231	11 297	110,4%
	nem szakorvosi	7 315	7 862	107,5%
Egy órára jutó	**eset**	15,06	15,42	102,3%
	beavatkozás	167,32	174,82	104,5%
	pont	34 144,97	35 786,88	104,8%

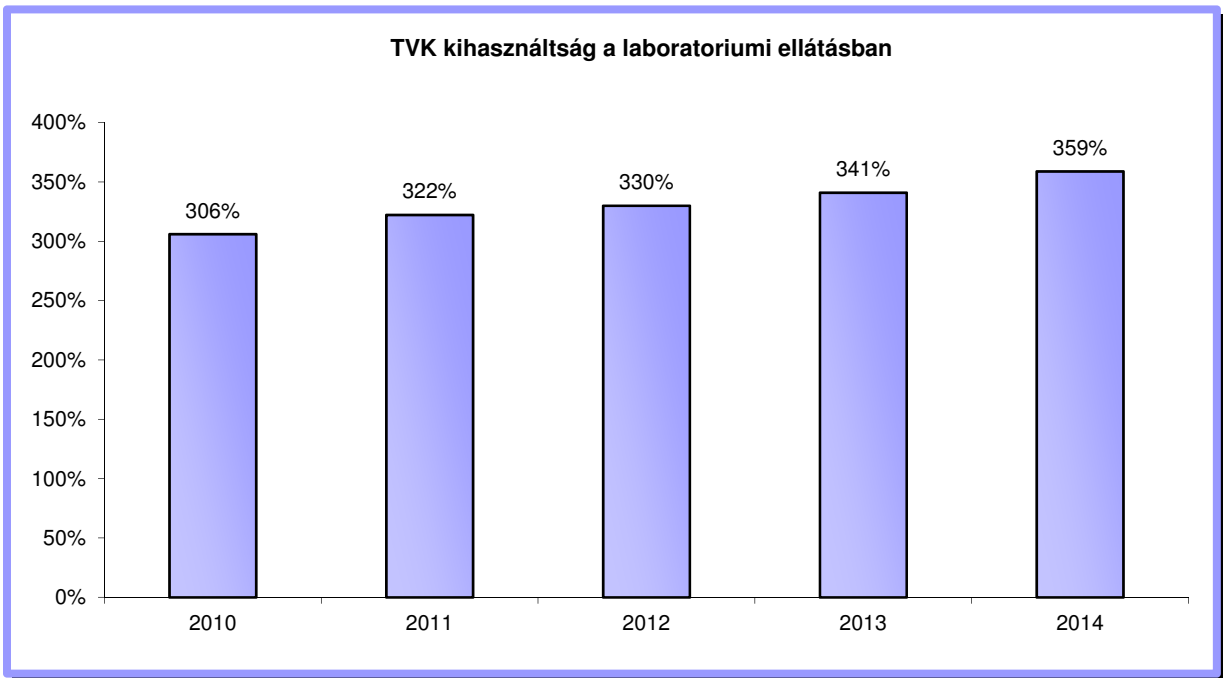
Az esetszám továbbra is emelkedést mutat, aminek okai összetettek.

Egyfelől a lebegő finanszírozás egyik ismert „mellékhatása”, hogy a szolgáltatók a teljesítmény folyamatos növelésében érdekeltek: a zárt kassza miatt akkor is csökken a bevétele, ha a havi teljesítménye állandó, de a többi szolgáltató folyamatosan növeli a saját teljesítményét, mivel így az egy pontteljesítményre jutó forintösszeg egyre csökken, az állandó teljesítmény egyre kevesebbet ér. Ebből adódóan a szolgáltatók egymást hajszolják bele a mind magasabb teljesítésbe.

Másrészt az emelkedésben jelentős szerepe van annak a ténynek is, hogy a jelenlegi szabályozási környezetben a beutaló orvos sem érdekelt az indokolatlan vizsgálatok visszaszorításában.

Jelentősebb emelkedést mutatnak a kapacitásadatok: az elmúlt két év vonatkozásában átlagosan mintegy 10,0 százalékkal bővült a laboratóriumi ellátás óraszáma, ugyanilyen arányban csökkentve ezzel az egyes szervezeti egységek órára jutó terhelését.

Az alábbi ábra a laboratóriumi TVK kihasználtságát mutatja be a 2014-es és az azt megelőző években.



A számok alapján egyértelmű növekedés mutatható ki az adatokban. A 2009. finanszírozási év óta elmondható, hogy egy labor TVK pontra három - három és fél labor pont teljesítmény jut. A többi TVK-val finanszírozott szakellátási kassza (járóbeteg-szakellátás, aktív fekvőbeteg-szakellátás) TVK kihasználtságának adatai fényében talán magasnak tűnhetnek ezek a számok.

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a TVK rendszer laboratóriumi ellátásban történő bevezetését (2006. február) követő kezdeti időszakban (a teljesítmények egy részét a szolgáltatók egy előre meghatározott, saját keret mértékéig fix – a járóbeteg-szakellátáséval megegyező – forint/pont értéken számolhatják el), a laboratóriumi ellátás átlagos, egy pontra jutó forintértéke jelentősen elmaradt a járóbeteg-szakellátás forint/pont értékétől.

Kizárólag egy mesterségesen magasan tartott kihasználtság (mesterségesen alacsony TVK keret) mellett lehetett a szinte változatlan nagyságú laboratóriumi előirányzatból, a szintén változatlan (de inkább lassan növekvő) teljesítményt finanszírozni.

Az alábbi táblázat a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) teljesítmény adatainak alakulását tartalmazza a 2013-2014. évi adatok összehasonlításával.

Megnevezés	**2013. év**	**2014. év**	**Változás 2013-ról 2014-re**
Beavatkozások száma	376 192	384 903	102,3%
Esetszám (Vizsgálatkérés)	99 116	94 974	95,8%
Egy esetre jutó beavatkozás	3,80	4,05	106,8%
Pont	1 822 541 555	2 034 104 041	111,6%
Egy esetre jutó pont	18 388	21 417	116,5%

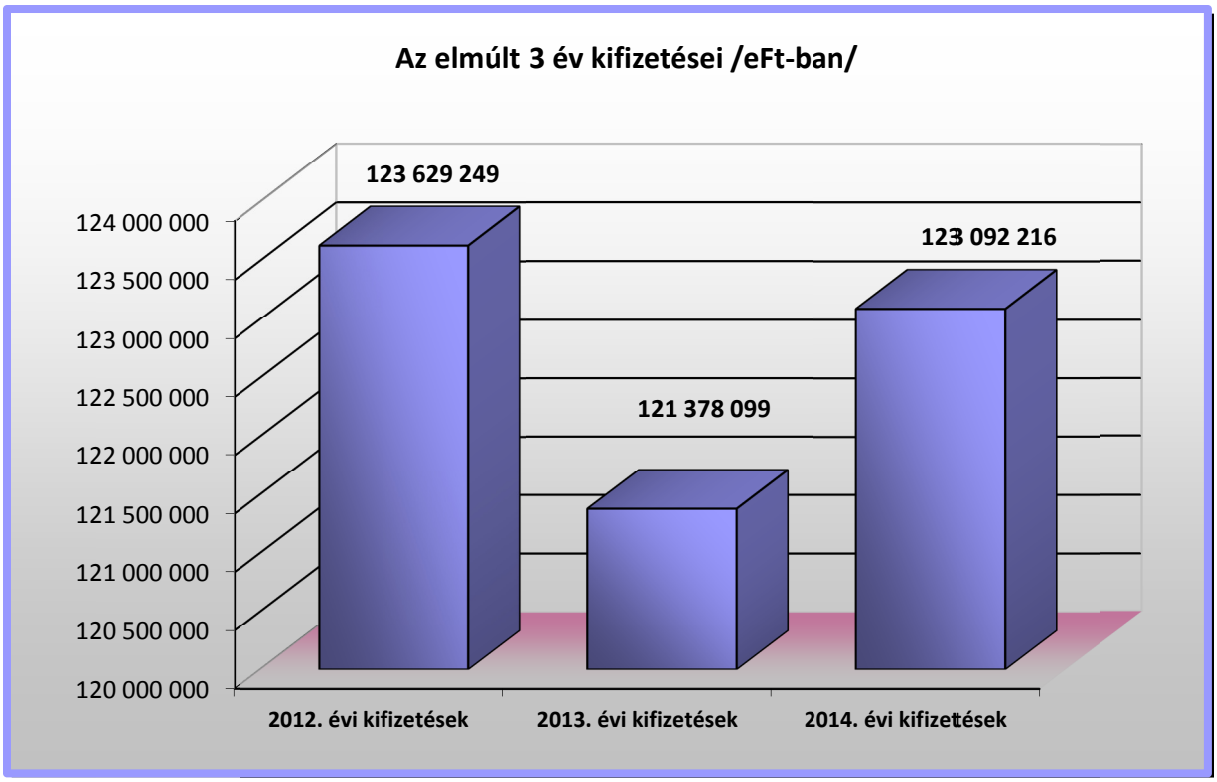
A molekuláris genetikai vizsgálatok azon korszerű vizsgálati módszerek közé tartoznak, melynek segítségével pontosítható a diagnózis és hatékonyabbá tehető egyes betegségek kezelése. A molekuláris genetikai vizsgálatok körében annak ellenére, hogy 2008-2014. viszonylatában nem változott e vizsgálatok finanszírozására rendelkezésre álló keret, a beavatkozások száma jelentős mértékben emelkedett. A technológia előnyeinek felismerése a vizsgálatkérések számának további emelkedését vetíti elő.

Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

A teljesítmény alapján finanszírozott járóbeteg-szakellátás (szakrendelések és szakambulanciák, a CT, MRI diagnosztikai ellátás, valamint a gondozóintézetek által nyújtott és teljesítményként elszámolható szolgáltatások) finanszírozására 2014. évben a költségvetés együttesen 121 454,2 millió forintot irányzott elő, mely az évközi előirányzat-átcsoportosításokat követően 123 092,3 millió forintra emelkedett. Az éves kifizetés (123 092,2 millió forint) 1,4 százalékkal haladta meg az előző évi kifizetést.

Az elmúlt három év során az alábbiak szerint alakultak a járóbeteg-szakellátásra (általános járóbeteg-ellátásra, CT-MR vizsgálatokra, gondozói teljesítményre) történt kifizetések.



A 2014-es finanszírozási évben a járóbeteg teljesítmények elszámolása a TVK finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére az ott szereplő TVK többlet ponttal.

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK-t meghaladta.

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített népegészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló pont mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében - járóbeteg szakellátást érintően - a 2014. évben 7,0 millió forint került kifizetésre.

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg-szakellátásra és járóbeteg-szakellátásra szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell határozni a hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket.

Ennek megfelelően a 2013. november és december hónapokra a 2013. finanszírozási évben megállapított teljesítmény volumen korlát időarányos része (azaz a 2012. november - 2013. október időszakra vonatkozó TVK kétszer 1/12-ed része) kerülhetett az OEP-pel szerződésben álló szolgáltatók részére meghatározásra és kiközlésre, 2013. október hó során. Továbbá 2013. december során kiközlésre kerültek a 2014. január havi, előzetes, átmeneti keretszámok is, a szolgáltatók időben való tájékoztatása érdekében.

A Kt. elfogadása után az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította a Kr.-t. A módosított finanszírozási szabályozásnak megfelelően meghatározásra kerültek a 2014. finanszírozási évre vonatkozóan, a 12 havi – kasszánkénti bontású – TVK értékek, melyek a szolgáltatók részére 2014. január elején kerültek kiközlésre. A korábban kiközölt háromhavi, 2013. november-2014. január havi TVK az éves keret részét képezte. A fennmaradó időszakra vonatkozó TVK – fekvő- és járóbeteg-szakellátás esetén – a Kr. 28. számú mellékletében rögzített országos szezonális index arányában került felosztásra.

A beszámolási időszakban érvényes forint -/ pont érték 1,50 forint volt.

A degressziós sávok mértéke a 2013. november havi teljesítmények elszámolásától kezdődően változtak, azaz járóbeteg-szakellátás esetén – az ezt megelőző időszak két sávjához képest - az OEP a többletteljesítményt 10,0 százalékig 30,0 százalékos, 10,0 és 20,0 százalék között 20,0 százalékos alapdíjjal számolta el.

A Kr. szabályozása alapján a fenntartó kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítást. A GYEMSZI, mint a legtöbb szolgáltató fenntartója a beszámolási év során nem élt e jogszabályi lehetőséggel.

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2013. december 3-ától hatályos módosítása szerint az egészségügyi szakmák és azok kódjai módosultak, mely kódok miatt aktualizált szerződéskötések a beszámolási évben folyamatosan megtörténtek, együttműködve az OTH és az ÁNTSZ területi Hivatalaival.

A járóbeteg-szakellátás (szakrendelések + szakambulanciák + CT, MRI + gondozói teljesítmény) 2014. évi főbb finanszírozási paraméterei az előző két évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

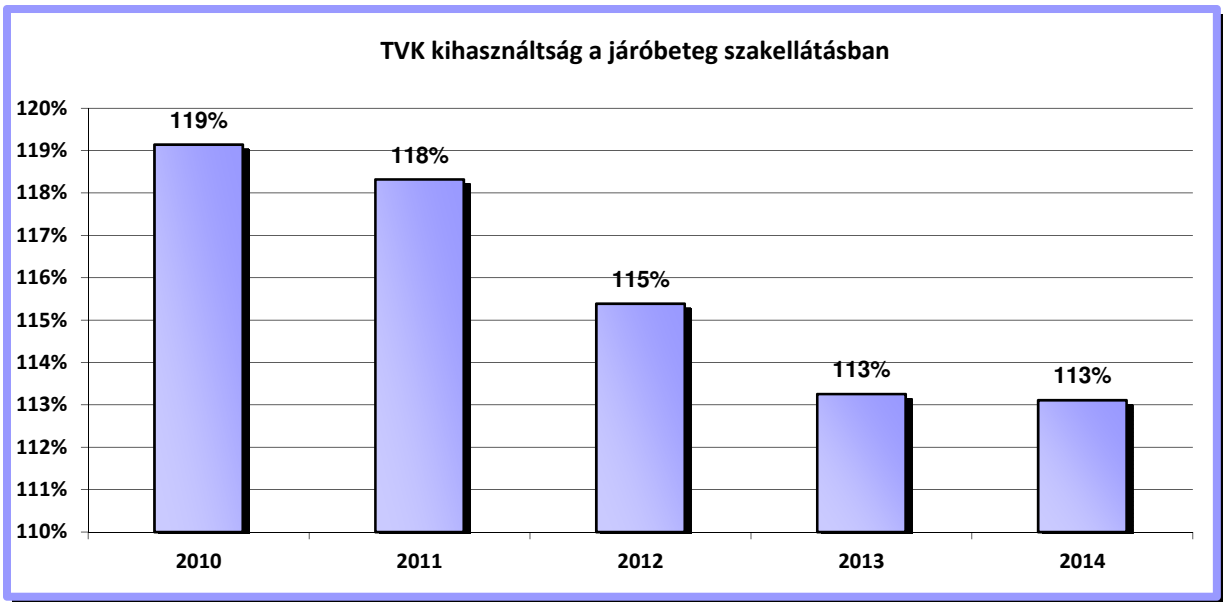
Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	Változás 2013-hoz képest
Finanszírozott esetszám	52 494 131	51 743 101	52 413 446	101,30%
Finanszírozott beavatkozások száma	204 403 041	203 302 117	207 098 303	101,87%
Elszámolt pont	88 059 578 063	87 748 918 184	89 867 080 541	102,41%
Teljesítmény díj (Ft)	116 780 092 108	116 878 807 361	121 349 378 078	103,82%
Az elszámolt pontból szűrés	1 254 403 689	1 197 828 538	1 199 544 991	100,14%
A teljesítmény díjból szűrés	1 875 669 692	1 789 957 770	1 791 130 387	100,07%
5 perces szabály/minimum idő hatása (Ft)	-604 009 352	-669 080 058	-524 671 986	78,42%
Részl. térítési díj miatti visszavonás (Ft)	-9 208 031	-9 926 932	-8 436 950	84,99%

A következő ábra a 2014. évre vonatkozó járó TVK és teljesítmény adatokat mutatja be:

Megnevezés	2014. év
TVK	78 089 416 755
Jelentett teljesítmény (pont)	88 326 922 189
TVK-val (100%-on) elszámolt teljesítmény (pont)	77 216 532 840
Degresszáltan (30%-on) elszámolt teljesítmény (pont)	5 008 125 933
Degresszáltan (20%-on) elszámolt teljesítmény (pont)	3 184 478 814
Ki nem fizetett teljesítmény (el nem számolható pont)	1 540 552 543
Göngyölített maradvány	874 526 167
TVK kihasználtság	113.11%

A TVK mennyisége átlagosan havi 6 507 451 396 pont volt, melynek tényleges havi eloszlását befolyásolta, hogy a szolgáltatóknak lehetőségük volt az országos szezonális index helyett saját intézményi TVK felosztást megadni a 2014. január-október közötti időszakra.

A járóbeteg-szakellátás TVK kihasználtsága az alábbiak szerint alakult az elmúlt, teljesítményvolumen alapján finanszírozott években.



A TVK kihasználtság átlagos szintje a 2013-as szinthez képest nem mutat változást. Továbbra is elmondható, hogy a finanszírozás 2011. januártól való „fellazítása” – azaz, hogy a 100,0 százalék fölött jelentett teljesítmények is újra finanszírozhatók lettek – nem járt együtt a teljesítmények felpörgetésével.

A beszámolási időszak alatt többletkapacitás-befogadási eljárás keretében három alkalommal, összesen 21 szolgáltató részére került többletkapacitás befogadásra *az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény* végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján, melyekről az OEP főigazgatója Közleményt jelentetett meg. A Közlemények egészségügyi szolgáltatónként tartalmazták a befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, valamint a finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontját. A határozatlan időtartamú finanszírozási szerződések megkötésére legkorábban 2014. január 1-jétől, 2014. április 1-jétől, illetve 2014. szeptember 1-jétől kerülhetett sor. A kihirdetett befogadásoknak megfelelően 16 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés. Két szolgáltató nem élt a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási időpontot követően 1 éven belül nem kezdeményezi a szerződés megkötését, ezért a két szolgáltató már nem is élhet a szerződéskötés lehetőségével.

A TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott járóbeteg-szakellátási többlet-kapacitásokra 11 szolgáltatóval történt szerződéskötés. Egy újonnan létrejövő egészségügyi szolgáltató volt, a többi esetében a meglévő szakmák és az ahhoz tartozó kapacitások bővítésére került sor.

Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról szóló 1876/2013 (XI.28.) Korm. határozat 1. melléklete alapján közfinanszírozott szolgáltatók befogadást nyertek egyéni,

valamint csoportos dohányzás leszoktatást célzó indexes OENO-k végzésére, többlet óraszám befogadása mellett. A finanszírozási szerződéskötés legkorábbi időpontja 2013. december 1-je volt. A beszámolási időszak alatt egyéni leszoktatás tevékenységre 66 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés, melyből egy szolgáltatóval ugyanebben az évben e tevékenységre vonatkozóan meg is szűnt a finanszírozási szerződés.

A csoportos dohányzás leszoktatás tevékenység végzésére befogadott többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerződések megkötésének legkorábbi időpontja 2015. január 1-je, így ezeknek a szerződéseknek a megkötése a beszámolási időszakot nem érintette.

Az NM rendelet 2014. január 21-étől hatályos módosításának megfelelően az újonnan kihirdetett 11064 OENO kódot magába foglaló 47-es indexre, amely a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése irányul megtörtént a szerződéskötés a rendeletben megjelölt szolgáltatóval 2014. január 01-jei hatállyal.

Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet alapján az NM rendeletben módosításra kerültek a Transztelefonikus EKG ellátáshoz kapcsolódó OENO kódok és a hozzájuk tartozó pontértékek.

A járóbeteg-szakellátás területét érintő orvosszakmai-helyszíni ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek alapján 2014. évben összesen 2 647 278 pont került levonásra. Az OEP Elemzési, Orvosszakmai és Szakmai Ellenőrzési Főosztálya által javasolt tételek visszavonása során 3,3 millió forint teljesítménydíj és 205,3 ezer forint kamat érvényesítésére került sor.

CT, MRI diagnosztika

Az összevont szakellátás jogcímen belül a CT és MR diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására 2009. évtől elkülönített forrás nem áll rendelkezésre, a finanszírozás járóbeteg-szakellátás előirányzata terhére történik. E nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokra a 2014. évben 17 271,2 millió forint kifizetés történt, azaz 0,8 százalékkal több, mint a 2013. évben.

Az OEP 2014. október 31-ei állapot szerint 78 db CT berendezést és 33 db MR készüléket finanszírozott. Az alábbi táblázat a CT és az MR diagnosztikai vizsgálat- és betegszámok alakulását mutatja be az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés	2013. év		2014. év		2014/2013 vizsgálatszám
	Vizsgálat szám	Betegszám	Vizsgálat szám	Betegszám	
CT	871 723	400 657	948 091	425 791	108,76%
MR	336 893	201 840	347 388	207 148	103,12%
Összesen	1 208 616	602 497	1 295 479	632 939	107,19%

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtásáról rendelkező 337/2008 (XII.30.) Korm. rendelet alapján 5 db MRI és 3 db CT gép került befogadásra, melyből 2 db MRI és 3 db CT gép leszerződése megtörtént.

TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott többletkapacitásokra 1 szolgáltatóval történt MRI készülék finanszírozására-, és 2 szolgáltatóval CT készülék finanszírozására szerződéskötés.

Fekvőbeteg-szakellátás

Aktív fekvőbeteg-szakellátás

Az E. Alap 2014. évi költségvetése az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására együttesen 356 709,4 millió forintot irányzott elő. Az évközi átcsoportosítások eredményeképpen az előirányzat 363 474,9 millió forintra módosult. Az éves kifizetés 363 456,4 millió forint volt, amely 5,6 százalékkal haladta meg az előző évi teljesítés mértékét.

A 2014-es finanszírozási évben az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítmények elszámolása a TVK-finanszírozás szabályai szerint történt.

A 2013-as beszámolási évhez hasonlóan a szakellátási éves TVK kereteket a Kr. 28/A. számú melléklete határozta meg az egyes szolgáltatókra vonatkozóan. A feltüntetett TVK nem csak az aktív fekvőbeteg szakellátási súlyszámokat, hanem az egynapos súlyszám keretek éves mértékét is tartalmazta.

Az éves TVK részét képezte a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló ún. „Miniszteri-tartalék”, 667 súlyszám mértékben. A Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére 617 súlyszám került meghatározásra. A vastagbélszűrési pilot program keretében – a fekvőbeteg szakellátást érintően – a 2014. évben 8,5 millió forint került kifizetésre.

A beszámolási év elején a TVK kiközlése a járóbeteg-szakellátási részben leírtakkal azonos módon történt.

Az alapdíj a beszámolási időszakban 150 000 Ft/súlyszám volt.
A következő táblázat a 2014. évre vonatkozó fekvő TVK és teljesítmény adatokat mutatja be:

Megnevezés	**2014. év**
TVK	2 002 540,56
Jelentett teljesítmény (súlyszám)	2 042 640,17
Jelentett TVK mentes teljesítmény (súlyszám)	247 084,50
Összes jelentett teljesítmény (súlyszám)	2 289 724,66
TVK-val és mentesen (100%-on) elszámolt súlyszám	2 236 948,49
Degresszáltan (25%-on) elszámolt súlyszám	31 993,82
Göngyölített maradvány (súlyszám)	12 676,57
TVK kihasználtság	102,00%

A TVK mennyisége átlagosan havi 166 878 súlyszám volt.

A 2014. finanszírozási évben a TVK mentesen elszámolható tevékenységek köre jelentősen kibővült, a 2014. január havi teljesítmények elszámolásától kezdődően. A TVK megállapítása alóli kivételek és elszámolásuk feltételeit a Kr. 27. § (7) bekezdése tartalmazza, ezek közül az újonnan bekerülő TVK mentes ellátások a Kr. 28/B. számú mellékletében kerültek feltüntetésre és továbbra is TVK mentesen volt elszámolható a szülési- és újszülött ellátások, valamint a patológiai ellátások teljesítménye. A jelentett TVK mentes teljesítmények mennyisége 34,3 százalékkal növekedett a megelőző évhez képest.

A degressziós sávok mértéke nem változott; az OEP legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt számolt el 25,0 százalékos alapdíjon.

A GYEMSZI, mint a legtöbb szolgáltató fenntartója – hasonlóan a járóbeteg szakellátáshoz – nem élt a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítás jogszabályi lehetőségével.

Az aktív fekvőbeteg-szakellátás főbb finanszírozási paramétereinek alakulását az elmúlt három év összehasonlításában az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Éves átlagos ágyszám	44 340	43 528	42 197	42 138
Az év folyamán működött osztályok száma	1 826	2 188	1 984	1 851
Súlyszám összeg	2 307 243	2 303 438	2 311 199	2 343 690
Finanszírozási esetszám	2 221 578	2 378 920	2 076 831	2 111 978
Meghalt (patológia nélkül)	55 497	56 275	55 442	54 912
Halálozási arány	2,5%	2.4%	2.7%	2.6%
Ápolási nap	12 350 743	12 727 348	12 414 363	12 395 726
Egy esetre jutó nap	5,6	5.4	6.0	5.9
Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám összeg	4,3	4.4	4.6	4.6
Egy ágyra jutó esetszám / hó	4,2	4.6	4.1	4.2
CMI	1,04	1.03	0.90	0.90
Ágykihasználtság	76,3%	80.1%	80.6%	80.6%
Elszámolt teljesítménydíj (eFt)	330 853 016	329 691 318	335 569 138	344 639 078
Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)	7 462,0	7 574.3	7 952.5	8 178.8

A vizsgált időszakon belül a fontosabb és jellemző finanszírozási paraméterekben jelentős változás nem mutatható ki.

A beszámolás időszak alatt TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott többletkapacitásokra két szolgáltató esetében került sor szerződéskötésre, sürgősségi betegellátási tevékenység fejlesztésére.

Többletkapacitás-befogadási eljárás keretében (TBB) 11 szolgáltató részére kerültek többletkapacitások befogadásra. A beszámolási időszak alatt 10 szolgáltatóval megtörtént a szerződéskötés, egy szolgáltatóval pedig a 2015. év során.

Az egynapos sebészeti ellátásokat végző szolgáltatók részére a meghatározott TVK keret az előző évhez képest nem változott, a beszámolási év elején – négy szolgáltató kivételével – ugyanaz a súlyszám mennyiség került megállapításra a 2014. évre is; a négy szolgáltató esetében minimális TVK csökkenés került meghatározásra a Kr. 28/A. számú mellékletében.

Az egynapos ellátást végző szolgáltatók körét a beszámolási év során az uniós forrásokból megvalósuló, TIOP és ROP pályázatok keretében befogadást nyert egy új (járóbeteg) szolgáltató bővítette.

A következő táblázat a 2014. évi egynapos tevékenységre vonatkozó TVK és teljesítmény adatokat mutatja be:

TVK	Jelentett teljesítmény (súlyszám)	TVK-val 100%-on elszámolt súlyszám	Göngyölített maradvány (súlyszám)	TVK kihasználtság
38 629,63	37 151,15	35 900,32	2 731,54	96,17%

Az adatokból látható, hogy éves szinten a jelentett teljesítmény nem haladja meg a TVK mennyiségét, így a TVK kihasználtság nem éri el a 100,0 százalékot. Ez a mutató nagyon eltérő értéket mutat az ilyen típusú ellátást végző szolgáltatók között.

Év végén a göngyölített maradvány 2 731,54 súlyszám volt, ami 85,0 százaléka a havi átlagos egynapos TVK értéknek. A nagymértékű maradvány oka, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan vannak olyan szolgáltatók, amelyek sem a pályázat során részükre befogadott esetszámot, sem az ehhez elnyert súlyszám mennyiséget nem teljesítették, illetve a struktúraváltáskor egynapos tevékenységre visszaosztott TVK-t a beszámolási év során még nem tudták teljes mértékben kihasználni. Egynapos tevékenységre a beszámolási év során 5 385,0 millió forint került kifizetésre.

Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák díjazása a 2014. évben is havi fix összegben történt, mely fixdíjakat az NM rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. A díjak mértéke 2014. január 21-jei hatállyal megemelkedett. Az év során a kifizetések egyenletes ütemben történtek.

A járóbeteg-szakellátási TVK terhére végezhető egynapos beavatkozásokra a szolgáltatók 2008. július hónap óta köthetnek szerződést. Az ebben a körben végezhető beavatkozásokat az NM rendelet 9 sz. mellékletének IV. fejezete tartalmazza.

A jelentett teljesítmények elszámolása a fekvő és az egynapos elszámolásokkal egyidőben, de azoktól elkülönítetten történik. A beszámolási évben e tevékenységre 87,2 millió forint kifizetés történt, amely mindössze 1,6 százaléka az egynapos sebészeti tevékenység – azonos időszakra vonatkozó – kifizetésének.

A következő táblázat a 2014. évi járóbeteg-szakellátási TVK terhére végezhető egynapos ellátás TVK és teljesítmény adatait mutatja be:

TVK	Jelentett teljesítmény (súlyszám)	TVK-val 100%-on elszámolt súlyszám	Göngyölített maradvány (súlyszám)	TVK kihasználtság
634,80	597,66	581,23	3,34	94,15%

Az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás fejlesztésére 2 000 súlyszám TVK keret került meghatározásra, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra volt fordítható és elszámolható. A tevékenység végzésére jogosult öt szolgáltató részére a beszámolás év során 142,2 millió forint kifizetés történt. A jelentett teljesítmények elszámolása a fekvő és az egynapos elszámolásokkal egyidőben, de azoktól elkülönítetten történik.

Krónikus- fekvőbeteg-szakellátás

A krónikus fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására előirányzott 62 646,3 millió forint az előirányzat átcsoportosítások eredményeként 64 008,6 millió forintra módosult. Az éves kifizetés, amely megegyezett a módosított előirányzat összegével 1,5 százalékkal növekedett az előző évi finanszírozás összegéhez képest. Az év során a teljesítménydíjak havi kifizetése arányosan történt.

A vizsgált időszakban a krónikus és rehabilitációs ellátások tekintetében 2014. január 01-jétől az alábbi új ellátási formák kerültek bevezetésre.

Kódja	Megnevezése	Szorzója
00025	Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása	3,8
00029	Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás	1,8
00030	Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint***	1,2
00031	Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint****	1,4
00032	Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint*****	1,8

A beszámolási időszakon belül fontos változás, hogy a korábban méltányossági körbe tartozó otthoni tartós gépi lélegeztetett betegek ellátásának finanszírozása 2014. januártól kezdődően a krónikus fekvőbeteg szakellátás előirányzata terhére történik.
A krónikus rehabilitációs kapacitások ellátási forma- és a finanszírozás súlyozási szorzója szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be (2014. finanszírozási év utolsó havi adatai alapján). A krónikus súlyozási szorzókhoz tartozó ágyszámok – a tavalyi év ugyanazon időszakához képest – jelentősen eltolódtak a magasabb súlyozási szorzók felé:

Megnevezés	Szorzók	Ágyszám	Kapcsolódó osztály nappali kórházi beteglétszáma	Ágyszám változás 2014/2013
Ápolási tevékenység	1	2 495	0	1,8%
Krónikus ellátás	1,2	9 000	20	-1,1%
Súlyos kp.id.sérültek,politraumat,égés-,szept.seb.bet. rehab	3,8	390	0	2,6%
Rehabilitációs ellátás "A" minősítésű	1,8	8 004	141	5,1%
Rehabilitációs ellátás "B" minősítésű	1,4	1 585	348	-5,0%
Rehabilitációs ellátás "C" Minősítés nélkül	1,2	4 518	209	-15,7%
Hospice ellátás	1,7	200	0	0,0%
Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehab.ell.	6,6	18	0	0,0%
Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása	1,6	64	0	-
TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelés	1,6	24	0	-
Pszich. rehab. "A" szint	1,8	117	58	-

A beszámolási időszak teljesítményének jellemző mutatóit az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Ágyak száma (éves átlag)	27 250	26 877	26 822	26 655
Osztályok száma	691	757	660	614
Súlyozott krónikus nap	10 908 369	11 040 205	11 280 512	11 407 499
Ápolási nap	8 099 327	8 361 851	8 426 323	8 431 998
Finanszírozási esetszám	303 056	297 342	300 144	288 617
Meghalt	25 457	25 464	25 556	25 724
Halálozási arány	8,40%	8,56%	8,51%	8,91%
Elszámolt teljesítménydíj (eFt)	61 124 074	61 521 923	63 165 975	63 881 993
DMI (súlyozott ápolási nap / ápolási nap)	1.35	1.32	1.34	1.35
Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt)	2 243	2 289	2 355	2 397
Ágykihasználtság	81,43%	85,24%	86,07%	86,67%

A rendelkezésre álló kapacitás (ágyszám) kis mértékben csökkent. A finanszírozási esetszám a 2013. év adataival összehasonlítva 3,8 százalékkal csökkent. Az ápolási nap minimális mértékben növekedett és a súlyozott krónikus nap is emelkedett 1,1 százalékkal. A kapacitás kihasználtság a megelőző időszakban mért adathoz képest 0,6 százalékos növekedést mutat.

Az uniós forrásokból megvalósuló, TIOP és ROP pályázatok keretében a rehabilitációs ellátások fejlesztésére befogadott szolgáltatók közül két szolgáltatóval történt szerződéskötés.

Többletkapacitás-befogadási eljárás keretében 6 szolgáltató részére került sor többletkapacitás befogadásra, melyből a beszámolási időszak alatt 5 szolgáltatóval a szerződéskötés is megtörtént. Az év során további 1 szolgáltatóval történt a 2013. évi egyszerűsített eljárásban befogadott többletkapacitásként befogadott rehabilitációs szorzóváltásra vonatkozó szerződéskötés.

Extrafinanszírozás

Extrafinanszírozás a Kr. 45. §-a alapján a fekvőbeteg szakellátó egészségügyi szolgáltatók a betegellátást követően egyedi kiegészítő finanszírozást igényelhetnek részletes költségkimutatással együtt az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül, amennyiben a betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét meghaladta.

A Kr-ben a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcímén belül az Extrafinanszírozás fedezetére 500,0 millió forint állt rendelkezésre.

2014. év folyamán 13 egészségügyi szolgáltató 66 kérelme került feldolgozásra és azokból 56 kérelem került engedélyezésre. Az igényelbírálás során 10 eset nem felelt meg a finanszírozási feltételeknek, ezért azok elutasításra kerültek. Az 56 engedélyezett igényből 52 került finanszírozásra, a fennmaradó 4 ellátási eset engedélyezett kiegészítő finanszírozása az éves előirányzat kimerülése miatt áthúzódott a 2015. költségvetési évre. Az összesen közel 95 millió forint értékű extrafinanszírozás 2015-ben került kiegyenlítésre.

Ezen kívül 21 db, az egészségbiztosítóhoz 2014. év végén érkezett kérelem (13 TAJ) feldolgozása áthúzódott a 2015. évre. Ezeknek az igényeknek az értéke összesen 95,2 millió forint, szakmai ellenőrzésük folyamatban van.

A legtöbb kérelem országos intézetektől és klinikáktól érkezett be, 24 beteg esetében összesen 120,1 millió forint értékben, míg a legnagyobb összegű kifizetések fővárosi kórházak felé történtek, 12 beteg esetében összesen 289,3 millió forint értékben.

Speciális finanszírozású szakellátás

Az NM rendelet, illetve a Kr. szabályai alapján az OEP a rendelkezésre álló költségvetési irányzat alapján meghatározott éves keretszám erejéig finanszírozza a tételes elszámolású eszközök, eljárások és gyógyszerek felhasználását a kijelölt szolgáltatók részére.

Az összevont szakellátás költségvetési soron belül a speciális finanszírozású szakellátás 2014. évi előirányzata 72 645,3 millió forint volt. Az előirányzat terhére az NM rendelet 1. számú melléklete szerinti tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok, az 1/A. számú melléklete szerinti tételes elszámolású gyógyszerek, valamint a 8. számú melléklete szerinti nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások finanszírozására 85 044,9 millió forint került kifizetésre.

Tételes elszámolású eszközök és eljárások

A tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok, valamint a nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások finanszírozása összesen 38 319,7 millió forint kiadást jelentett a 2014. költségvetési évben.

Ezen összegből 8 252,3 millió forint a közbeszerzési eljárás alapján beszerzett eszközök ellenértékeként került kifizetésre, mely összeg tartalmazza:

- a 2013. évi közbeszerzések útján természetben biztosított közép és belső fül implantátumok szerződéseinek meghosszabbítása révén beszerzett eszközök értékét, valamint
- a 2014. évben lefolytatott közbeszerzés révén biztosított eszközök (közép és belső fül implantátum, pacemaker, ICD, szívbillentyű) 2014-ben kifizetett értékét.

Közbeszerzési eljárás alapján beszerzett eszközökre 22,2 százalékkal magasabb kifizetés történt 2013-hoz képest, ez a növekedés a beszerzett eszközök darabszámának hasonló arányú emelkedése miatt következett be.

Az OEP által nem természetben biztosított eszközökre és nagy értékű eljárásokra 2014. évben 30 067,3 millió forint volt a kifizetés, melyből

- 14 680,4 millió forint volt a kórházak által beszerzett és felhasznált eszközök (pl. neuropacemaker, scoliosis implantátum) utólagos finanszírozása, továbbá
- 15 386,9 millió forint az elvégzett nagy értékű eljárások (transzplantáció, PET/CT) térítése.

Előző évhez képest a nem természetben biztosított eszközökre kifizetett összeg (négy, újonnan finanszírozásba bevont eszköz mellett) 25,3 százalékkal nőtt, mely a növekvő betegszám miatt következett be.

Az elszámolt transzplantációs, terápiás aferezis és fotoferezis, valamint a képalkotó diagnosztikai eljárásokat érintő esetszámok emelkedése, továbbá öt új eljárás finanszírozásba való bevonása a kifizetésekben 2013-hoz képest 17,6 százalékos növekedést eredményezett.

Az esetszámok változását az alábbi táblázat foglalja össze:

Eljárás	2013. évi elszámolt esetszám	2014. évi előirányzat szerinti esetszám	2014. évi elszámolt esetszám	2014 elszámolt / 2014 előirányzat szerinti esetszám	2014/ 2013 elszámolt esetszám
	db	db	db	%	%
Transzkatéteres aorta műbillentyű implantáció	65	72	108	150,00%	166,15%
Szívtranszplantáció	46	39	53	135,68%	115,22%
Műszív beültetése transzplantációra váró betegnél	37	41	26	63,41%	70,27%
Albuminkezelésen alapuló májpótló kezelés	9	90	25	27,78%	277,78%
Májtranszplantáció	42	59	68	115,25%	161,90%
Hasnyálmirigy transzplantáció	8	19	13	68,42%	162,50%
Vesetranszplantáció	293	347	378	108,93%	129,01%
Felnőtt allogén csontvelőtranszplantáció	80	80	80	100,00%	100,00%
Felnőtt autológ csontvelőtranszplantáció	209	210	207	98,57%	99,04%
Gyermek allogén csontvelőtranszplantáció	33	36	29	80,56%	87,88%
Gyermek autológ csontvelőtranszplantáció	21	24	24	100,00%	114,29%
Unrelated csontvelőtranszpalntáció	57	65	69	106,15%	121,05%
Őssejt szelekció	2	8	2	25,00%	100,00%
Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálat	221	274	229	83,58%	103,62%
Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálat	254	250	194	77,60%	76,38%
Terápiás aferezis, haemaferezis	4 217	4 371	4 504	103,04%	106,81%
Fotoferezis	1 098	1 117	1 136	101,69%	103,46%
PET/CT diagnosztika	14 247	15 648	16 255	103,88%	114,09%
Tüdőtranszplantáció		10	0	0,00%	
Kiterjesztett speciális gerincműtét		84	59	70,44%	
Kombinált ventro-dorsalis speciális gerincműtét		34	7	20,66%	
Kiterjesztett speciális idegsebészeti műtétek		83	28	33,54%	
Kombinált speciális idegsebészeti műtétek		35	14	40,00%	
Összesen	**20 939**		**23 508**		**112,27%**

Tételes finanszírozású hatóanyagok

A tender alapján beszerzett és a szállítók felé kifizetett gyógyszerek ellenértéke a 2014. évben 46 101,4 millió forint volt, amely összeg tartalmazza a 2013. évről áthúzódó, valamint a közbeszerzési eljárás alapján a 2014. évre kötött szállítói szerződések alapján kifizetett összegeket:

- a hatályos jogszabályoknak megfelelően beérkezett teljesítményjelentések alapján keletkezett kiadásokat, továbbá

- azon gyógyszerek ellenértékét, melyek felhasználása az OEP és a szállítók között megkötött szerződésben rögzített alapmennyiséget nem érte el, de amely mennyiséget az OEP köteles megvásárolni. Ezen gyógyszermennyiséget az egészségbiztosító részére az elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltatók javára elkülönített raktárban helyezték el a szállítók.

További 623,9 millió forint került kifizetésre az egészségügyi szolgáltatók felé, az általuk beszerzett humán immunglobulin felhasználások után. Tételes elszámolású gyógyszerre a 2014. évben összességében a 2013. évinél 26,4 százalékkal nagyobb összeg, 46 725,2 millió forintot fordított az OEP.

A már finanszírozásban lévő *30 készítmény* mellé 2014-ben további *6 készítmény* (Inflectra, Eylea, Gammanorm, Humaglobin, Hizentra, Octagam és Privigen) került bevonásra.

Az alábbi táblázat azon 28 készítmény egyedi szerződésben rögzített értékét hasonlítja össze, amely készítményeket 2013-ban és 2014-ben is természetben biztosított az OEP:

OENO	Hatóanyag	Szerződéses bruttó összeg összesen		Változás
		2013. (ezer Ft)	2014. (ezer Ft)	2014/2013
06011, 06012	pemetrexed	1 152 295,7	1 512 500,4	31,26%
06036, 06037	bevacizumab	6 007 715,8	5 013 036,0	-16,56%
06014	cetuximab	1 325 625,0	2 499 997,5	88,59%
06071	panitumumab	393 179,1	1 922 209,4	388,89%
06010	trastuzumab	4 290 238,2	4 130 277,6	-3,73%
06061	lapatinib	312 889,5	374 012,1	19,53%
06013	gefitinib	400 550,1	486 560,8	21,47%
06046	erlotinib	648 251,1	921 978,8	42,23%
06038	nelarabin	91 618,4	43 773,4	-52,22%
06047	klofarabine	126 000,0	85 680,0	-32,00%
06058	rituximab (HEM)	3 277 732,5	3 261 489,0	-0,50%
06067	plerixafor	151 704,0	285 111,5	87,94%
06060	bortezomib	2 186 184,0	2 191 123,2	0,23%
06059	ibritumomab tiuxetan	78 728,5	17 713,9	-77,50%
06050	cetrolizumab	1 184 820,0	1 438 080,0	21,38%
06051	etanercept	3 956 400,0	2 983 190,7	-24,60%
06052	adalimumab	5 670 291,9	5 249 897,6	-7,41%
06058	rituximab (RA)	930 470,1	800 547,3	-13,96%
06053	infliximab	4 240 797,1	3 703 801,5	-12,66%
06054	tocilizumab	1 328 764,5	1 344 016,8	1,15%
06055	golimumab	1 968 480,7	2 118 472,0	7,62%
06056	ustekinumab	867 382,4	1 209 269,3	39,42%
06042	alteplase	620 109,0	312 480,0	-49,61%
06030, 06031	agalsidase beta	99 556,4	112 471,2	12,97%
06032	agalsidase alfa	754 542,3	764 625,2	1,34%
06040	ranibizumab	842 703,8	818 622,0	-2,86%
06041	verteporfin	2,1	8,3	297,52%
06043	palivizumab	290 850,0	872 550,0	200,00%

A kiadások emelkedése 2013-ról 2014-re a finanszírozási kör bővülésével és a nagyobb esetszámmal indokolható.

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a 2013-ról 2014-re milyen arányban változott a tényleges kifizetések mértéke, azon készítmények tekintetében, melyek mindkét évben a finanszírozási körbe tartoztak:

OENO	Hatóanyag	Tényleges kifizetés 2013. (bruttó ezer Ft)	Tényleges kifizetés 2014. (bruttó ezer Ft)	Változás (%)
06011, 06012	pemetrexed	1 121 001,7	1 501 143,2	+ 33,91%
06036, 06037	bevacizumab	3 971 181,1	4 996 002,6	+ 25,81%
06014	cetuximab	1 639 782,1	1 373 562,6	-16,24%
06071	panitumumab	479 358,1	1 722 725,6	+ 259,38%
06010	trastuzumab	3 588 271,4	4 554 241,9	+ 26,92%
06061	lapatinib	293 485,5	344 421,0	+ 17,36%
06013	gefitinib	79 509,9	432 821,8	+ 444,36%
06046	erlotinib	662 689,1	812 945,0	+ 22,67%
06038	nelarabin	14 377,4	49 623,5	+ 245,15%
06047	klofarabine	25 200,0	42 840,0	+ 70,00%
06058	rituximab	3 540 933,0	4 377 438,3	+ 23,62%
06067	plerixafor	121 277,7	188 395,7	+ 55,34%
06060	bortezomib	1 902 857,9	2 621 324,7	+ 37,76%
06059	ibritumomab tiuxetan	27 226,9	8 856,9	-67,47%
06050	cetrolizumab	1 455 968,5	1 096 985,4	-24,66%
06051	etanercept	3 527 319,6	3 233 224,4	-8,34%
06052	adalimumab	4 753 536,6	6 645 930,9	+ 39,81%
06057	abatacept	78,2	42 353,2	+ 54037,25%
06053	infliximab	3 499 301,6	4 336 896,6	+ 23,94%
06054	tocilizumab	1 236 877,7	1 327 763,6	+ 7,35%
06055	golimumab	1 722 327,3	2 169 065,6	+ 25,94%
06056	ustekinumab	893 799,4	1 146 247,2	+ 28,24%
06042	alteplase	427 329,0	319 813,2	-25,16%
06030, 06031	agalsidase beta	119 922,0	110 343,8	-7,99%
06032	agalsidase alfa	519 002,0	807 678,7	+ 55,62%
06040	ranibizumab	741 305,2	754 923,7	+ 1,84%
06041	verteporfin	0,5	3,2	+ 558,30%
06043	palivizumab	290 850,0	864 065,9	+ 197,08%
06044	humán immunglobulin	248 330,4	745 442,2	+ 200,18%
		36 903 099,8	**46 627 080,5**	**+ 26,35%**

Finanszírozási technikák

Alapvetően kétféle finanszírozási technikát különböztetünk meg:

I. Közbeszerzési eljárás alapján az OEP által beszerzett, így az egészségügyi szolgáltatók részére természetben biztosított eszközök, gyógyszerek. Az így beszerzett tételek ellenértékét az egészségbiztosító nem a szolgáltató, hanem a szerződött szállító részére fizeti meg.

II. Számlás eszközök, gyógyszerek valamint eljárások, melyek esetében az OEP az elvégzett ellátások után járó finanszírozást a kórházak részére utalja.

A Kr. 43. § (3) és (4) lehetőséget nyújt a finanszírozó részére az eszközök és hatóanyagok természetben történő biztosítására. Néhány nagyértékű eszköz és szinte valamennyi gyógyszer esetében az OEP – közbeszerzési eljárást követően – természetben biztosítja az elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltatók részére a betegek ellátásához szükséges eszközöket, (szívbillentyű, cochleáris implantátum, pacemakerek, ICD, elektródák) valamint gyógyszereket, melyeket a szállítók, forgalmazók közvetlenül az egészségügyi szolgáltatók részére juttatnak el.

A nagy értékű eljárások (transzplantációk, PET/CT ellátások), valamint egyszer használatos eszközök (pl. HALO készülék, orbitalis implantatum) és egyes gyógyszerkészítmények (primer immunhiányos állapotok kezelésére szolgáló immunglobulinok) esetében az OEP az egészségügyi intézmények által elvégzett ellátásokat, felhasznált eszközöket illetve tételes finanszírozású gyógyszereket utólagosan, havonta megküldött teljesítményjelentés részeként jelentik az OEP felé. Az eszközöket és gyógyszereket a kórházak szerzik be. Ezek költségét az elvégzett ellenőrzés és elszámolás alapján az OEP megtéríti az intézmény számára.

Főbb jogszabályváltozások

Az NM rendelet 1/a. mellékletét érintő, 2014. január 21-étől érvényes változás miatt egy új hatóanyaggal (aflibecept) bővült a tételes finanszírozású gyógyszerek listája. A 2014. év folyamán továbbá befogadásra került az infliximab hatóanyag bioszimiler készítménye is.

Az NM rendelet 1. számú melléklet Tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok jegyzéke 2014. január 21. napjától az alábbi eszközökkel bővült:

- video-thoracoscopos mellkasi (VATS) műtétek során használt varrógépek és tárak,
- kolorectális laparoszkópos bélműtétek során használt varrógépek és tárak,
- húgyhólyag műtétei során használt varrógépek és tárak.

Az NM rendelet 8. számú melléklet a nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételeinek jegyzéke 2014. január 21-étől az alábbiakkal egészült ki:

- tüdőtranszplantáció,
- kiterjesztett speciális gerincműtét,
- kombinált ventro-dorsalis speciális gerincműtét,
- kiterjesztett speciális idegsebészeti műtétek,
- kombinált speciális idegsebészeti műtétek.

Az OEP valamennyi új eszköz és eljárás elszámolására jogosult egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést kötött. Az intézmények részére biztosított pénzügyi keret felosztása során az OEP kikérte a Szakmai Kollégium illetékes Tagozatainak véleményét is.

Elszámoló rendszer

Jelenleg az OEP a tételes finanszírozású eszközök és eljárások vonatkozásában egy ún. offline elszámolási rendszert működtet. Ennek lényege, hogy az egészségügyi szolgáltatók által elvégzett ellátások jogszabályban (Kr.) rögzített részletezettségű adatait a kórház rögzíti. Az adatokat tárgy hónapot követő hó 5. napjáig az e-jelentés rendszerén keresztül küldi meg az OEP részére.

A tételes finanszírozású hatóanyagok vonatkozásában online jelentő felületet biztosít az OEP az egészségügyi szolgáltatók számára. A jelentőrendszer - az ún. adatlap.oep.hu címen - 2012. február 1-jétől kezdte meg működését. Az első néhány hónap tapasztalatai alapján a jelentőfelület megújításra került, és 2012. szeptember 3-ától elindult a ma is használt teteles.oep.hu felületen a megújult online jelentési rendszert. A szakmaspecifikus egészségügyi adatlapok részben a finanszírozás alapját képező elszámolási bizonylatként szolgálnak, részben a szakma képviselőivel folytatott konzultációk alapján elvégzett fejlesztések nyomán olyan adatok gyűjtésére alkalmas, amelyek a kezelések alakulásáról teljes körű, naprakész információt nyújthatnak mind a finanszírozó OEP, mind a szakma számára. A jelentő rendszer fejlesztésének célja, hogy segítséget adjon a felhasznált nagy értékű eszközök, gyógyszerek, eljárások forrásainak hozzárendelésében, vagy újraelosztásában, továbbá, hogy megalapozott információkat nyújtson.

Implantátum regiszter

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény megteremtette a Központi Implantátumregiszter létrehozásának jogszabályi alapját. *Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.)* 2014. január 1. napján hatályba lépő 101/C. §-a alapján valamennyi (közfinanszírozott és OEP-pel kötött finanszírozási szerződéssel nem rendelkező) egészségügyi szolgáltató az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről köteles az OEP által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást vezetni. Az Eü. tv. 101/B és 101/C pontjai alapján a Központi Implantátumregiszter technikai hátterét az OEP biztosítja. A jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget téve, a 2013. évi informatikai fejlesztés eredményeként 2013. decemberben teszt jelleggel, 2014. január 1-jétől élesben is elindította a Központi implantátum regiszter on-line rendszerét (impreg.oep.hu).

Az OEP jogszabályban rögzített kötelezettsége az informatikai on-line rendszer működtetése. A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatban felmerülő kérdések

és észrevételek kezelését az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal végzi, mellyel folyamatos az együttműködés.

Összességében a 2013. évhez képest a speciális finanszírozású szakellátás előirányzata (a 2014. december 19-ei döntést követően) 13,3 százalékkal emelkedett. Mindemellett az új befogadások révén a tételesen finanszírozott hatóanyagok száma 30-ról 36-ra, az egyszer használatos eszközök valamint eljárások köre három új eszközzel, illetve öt új eljárással bővült 2014-ben. A finanszírozási kör bővülése mellett emelkedő betegszámmal kell számolni, különösen az onkológiai és gyulladásos készítmények terén, valamint az életmentő kardiológiai eszközök felhasználása és a transzplantációs eljárások vonatkozásában.

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás

A 2014. évi gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásra fordított kiadás 4 258,3 millió forint volt, amely 58,3 millió forinttal, 1,4 százalékkal volt több az előirányzathoz képest. Az előző évhez viszonyított tényleges kifizetés 152,4 millió forinttal, 3,7 százalékkal emelkedett.

Anyatej ellátás

A 2014. évi anyatej ellátás támogatásra fordított kiadás 110,7 millió forint volt, 89,3 millió forinttal, 44,7 százalékkal kevesebb az előirányzatnál. Az előző évhez viszonyított tényleges kifizetés 30,8 millió forinttal, 21,8 százalékkal csökkent.

Gyógyszertámogatás

A Kt. a gyógyszertámogatási jogcímcsoportra összesen 294 114,0 millió forintot hagyott jóvá, amely az átcsoportosításokat követően 307 114,0 millió forintra módosult.

A jogcímcsoportot az alábbi előirányzat-módosítások érintették:

- A jogcímcsoporton belül a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím eredeti előirányzata 222 414,0 millió forint volt, mely 1 433,0 millió forinttal több, mint a 2013. évi eredeti előirányzat (220 981,0 millió forint). A gyógyszertámogatás kiadásai jogcím módosított előirányzata 286 454,0 millió forint lett.

  Év közben a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímről a speciális beszerzésű gyógyszerkiadásra miniszteri hatáskörben 500,0 millió forintot átcsoportosítása történt meg.
  A gyógyszertámogatás céltartalékról a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre tárgyév novemberében 45 040,0 millió forintot, majd ezt követően decemberben 6 000,0 millió forintot csoportosítottak át.
  A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI.

26.) Korm. határozat alapján a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím módosított előirányzata 13 000,0 millió forint összeggel megemelésre került, így az év végi módosított előirányzat 286 454,0 millió forint volt. A tárgyévi teljesítés Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímen 286 369,0 millió forint volt.

A jogcímen a 2014. évben történt elszámolások közül 2 446,3 millió forint összegű kifizetés 2015-ben teljesült.

Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím keretén belül az előirányzott 1 200,0 millió forintból 404,9 millió forint került kiutalásra finanszírozási előleg keretén belül, melyből összességében 4,5 millió forintot – haláleset következtében – nem fizetett vissza egy gyógyszertár.

A gyógyszertámogatási kiadások növekedésének megfékezése érdekében az elmúlt év folyamán több alkalommal és több gyógyszercsoport esetében került sor a referencia támogatási rendszerek újraszámolására. Így a hatóanyag- és terápiás referencia támogatások 4 alkalommal, az LMWH készítmények referencia támogatása 2 alkalommal, míg a biológiai gyógyszerekre vonatkozó referencia támogatás 1 alkalommal lett újraszámolva a gyártók és forgalmazók vaklicit során adott árcsökkentéseinek eredményét hasznosítva.

Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata terhére egyedi méltánylást érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló előirányzatként) 1 300,0 millió forint kiadást irányzott elő. E címen 2014. év folyamán 8 094,4 millió forint került kifizetésre. A növekedés hátterében a megnövekedett számú beteg igény áll, mely az új hatóanyagú, saját területén egyedülálló, a jelenleg támogatott gyógyszerekkel össze nem hasonlítható eredményességű készítmények hozzáférését biztosítja.

A közgyógyellátás keretében kiszolgált gyógyszerek támogatására 2014. évben 28 236,1 millió forint lett kifizetve. Ez az összeg 1 645,3 millió forinttal, azaz 5,5 százalékkal marad el a 2013. évi hasonló célú felhasználástól.

A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 2014. évi eredeti előirányzata 15 700,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 16 200,0 millió forint volt. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadásra a 2014. évben 15 935,0 millió forint kifizetésére került sor, mely összeg az eredeti előirányzatot 1,5 százalékkal haladja meg. A jogcímen a 2013. évi felhasználáshoz képest 10,0 százalékos felhasználás növekedés volt tapasztalható a Hepatitis C kezelések emelkedése következtében.

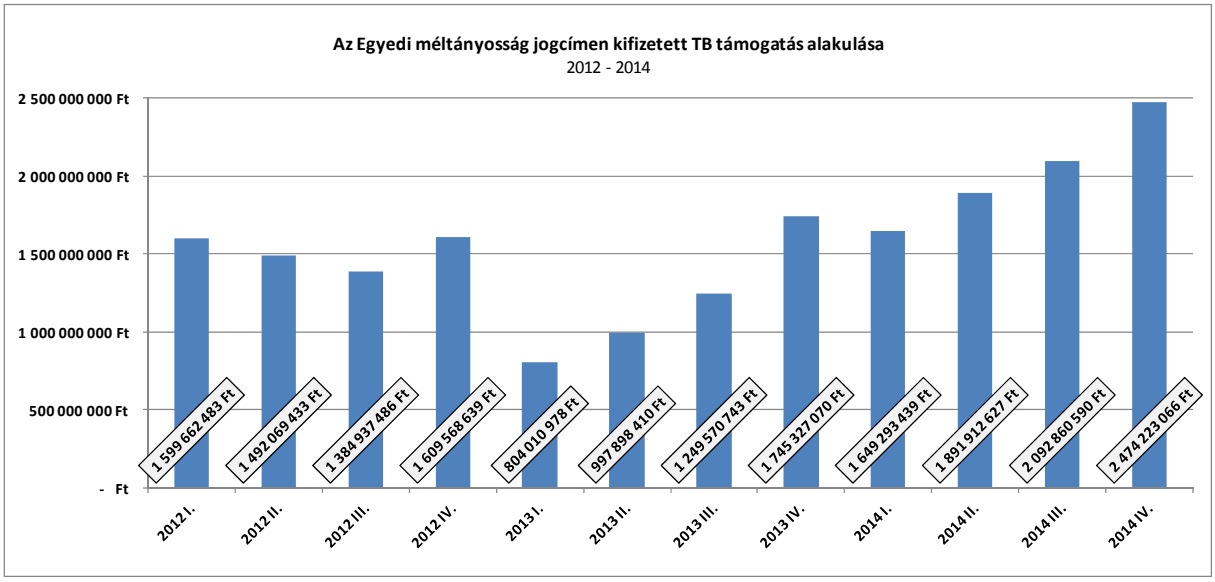
A gyógyszertámogatás céltartalék felhasználását a Kt. 18 §-a az alábbiakban szabályozza. A céltartalék törvényi előirányzata azt szolgálja, hogy az év közben beérkezett gyártói befizetések felhasználhatóak legyenek a kiadások finanszírozására. Ennek megfelelően, év közben a gyógyszertámogatás

céltartalék jogcímcsoportról 45 040,0 millió forint, a későbbiekben további 6 000,0 millió forint a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre, valamint további 500,0 millió forint a speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcímre került átcsoportosításra.

Gyógyszer méltányossági kifizetések

Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata terhére egyedi méltánylást érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló előirányzatként) 1 300,0 millió forint kiadást irányzott elő. E címen 2014. évben 8 094,3 millió forint került kifizetésre. A felhasznált összeg a 2013. évben hasonló célra történt felhasználásnál 3 600,4 millió forinttal magasabb.
Részletes, az egyes gyógyszerek forgalmának elemzésére is kiterjedő vizsgálatot csak a vényforgalmi szemléletben összesített adatokon tudunk végezni.

Az elmúlt években az egyedi méltányossági jogcímen kifizetett TB támogatásait – negyedéves bontásban – a következő diagram mutatja.



Az ábrából jól látható, hogy 2013. év elejétől az egyedi méltányossági támogatás formájában kifizetett TB támogatás összege folyamatosan növekszik. A növekedés hátterében az új hatóanyagú, saját területén egyedülálló, a jelenleg támogatott gyógyszerekkel össze nem hasonlítható eredményességű, de a TB támogatásba be nem fogadott készítmények egyedi méltányossági keretében történő TB támogatásának növekedése található.

2014-ben 4 050 betegnek biztosítottunk támogatást, mely 26 százalékkal több, mint az ezt megelőző évben (3205 beteg). Egyedi támogatással bíró készítmények forgalmának megközelítőleg 7,0 százaléka az Európai Unióban nem törzskönyvezett

készítményből (un. egyedi import készítmény) származó forgalom, ez a 278 készítményeknek közel egyharmada. Az elmúlt évben az onkológiai indikációkra több mint 4 300,0 millió forint támogatás kifizetése történt meg az egyedi méltányosság keretében.

Az elmúlt évek során a kérelmek száma az alábbiak szerint alakult:

	2010. év (db)	**2011. év (db)**	**2012. év (db)**	**2013. év (db)**	**2014. év (db)**
összes kérelem	**5741**	**2904**	**3069**	**3441**	**6054**
engedély	3407	1940	1685	2511	4985
elutasítás	677	434	448	447	448
megszüntető	439	122	68	154	111
más szervezeti egységhez történő átadás	196	50	23	63	44

A jelentős növekedést mutató egyedi méltányosság jogcím változásának hátterében részben a tavalyi évben 18 innovatív, igen magas támogatáskiáramlást eredményező, főleg onkológiai megbetegedésekben alkalmazható készítmény támogatása állt. A 2014-ban az egyedi jogcímen a legnagyobb TB kiáramlást okozó 10 készítmény támogatása tették ki a jogcímre kifizetett TB támogatás 41,0 százalékát, ami 506 beteg ellátását jelentette.

2014. év folyamán a 25 legjelentősebb támogatáskiáramlást generáló, egyedi méltányosságban támogatott készítményt összefoglaló táblázat a következő oldalon található. Megjegyzendő, hogy ezekre a készítményekre történt az Egyedi méltányossági TB támogatás kifizetések több mint 75,0 százaléknak a kifizetése.
A legtöbb ilyen jogcímen történt kifizetés a Zytiga, Zelboraf, Adcetris, Duodopa és a Stivarga esetében történt, míg a legmagasabb egy betegre kifizetett értékek a Novothirteen, Zavesca, Orfadin, Ilaris, Remodulin és Adcetris termékekhez köthető.

Gyógyászati segédeszköz támogatás

A gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport eredeti előirányzata 2014. évben 51 300,0 millió forintban került megállapításra. Az 56 120,0 millió forint módosított előirányzatból 2014. évben 55 947,7 millió forint kifizetés teljesült, amely 4 647,7 millió forinttal 9,1 százalékkal több az eredeti előirányzatnál és 4 488,5 millió forinttal 8,7 százalékkal több az előző évi teljesítésnél. 2015-ben 346,5 millió forint összegű 2014. évi kifizetés elszámolása történt meg.

Az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím eredeti előirányzata 45 000,0 millió forint volt.

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím módosított előirányzata 4 100,0 millió forint összeggel megemelésre került, így az év végi módosított előirányzat 49 100,0 millió forint volt. A jogcímről 49 098,5 millió forint került kifizetésre.

A kötszertámogatás jogcím tárgyévi előirányzata 6 000,0 millió forint volt, mely jogcímre év közben a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcímről további 180,0 millió forint került miniszteri hatáskörben átcsoportosításra.

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján a kötszertámogatás jogcím módosított előirányzata 720,0 millió forint összeggel megemelésre került, így az év végi módosított előirányzat 6 900,0 millió forint volt. A jogcímről 6 739,7 millió forint került kifizetésre.

A gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcím előirányzata 300,0 millió forint volt. Év közben a jogcímről 180,0 millió forintot került átcsoportosításra a kötszertámogatás jogcímre, így a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcím év végi előirányzata 120,0 millió forintra módosult. A gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcímről év végéig 109,5 millió forint került kifizetésre.

A gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére egyedi méltánylást érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló előirányzatként) 1 300,0 millió forint kiadást irányzott elő.

Egyedi méltányossági támogatás formájában 2014. évben 842,4 millió forint került kifizetésre, mely 457,6 millió forinttal marad el a tervezettől és a felhasznált összeg a 2013. évben hasonló célra történt felhasználásnál 224,1 millió forinttal azaz 36,2 százalékkal magasabb.

A közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközök a gyógyászat segédeszköz jogcímcsoport esetében a kiszolgált eszközök támogatására 2014. évben 11 175,8 millió forint lett kifizetve. Ez az összeg 46,2 millió forinttal, azaz 0,4 százalékkal marad el a 2013. évi hasonló célú felhasználástól.

Szakmai ellenőrzés

A 2014. éves országos ellenőrzési terv kialakításakor az OEP szakmai ellenőrzése vállalta, hogy folytatja a bázis ellenőrzést, amelynek célja, hogy az országos ellenőrző apparátus 5 év alatt valamennyi egészségügyi szolgáltatóhoz eljusson. Mindezt

arányosan tervezve, évente a szolgáltatói szegmens 20 százaléka kerül leellenőrzésre, konkrétan definiált kiválasztási módszertan szerint.

A 2014. évi bázis ellenőrzés
A vizsgálat 2014-ben is alapvetően átvilágító, feltáró jellegű volt. Amennyiben az OEP ellenőrző munkatársai szabálytalanságot észleltek, úgy szolgáltató-barát konzultációs jelleggel adtak javaslatot a hibás gyakorlat korrigálására, pontosabb működés kialakítására. Az ellenőrzés 2014-ben sem a szankcionálandó szabálytalanságok keresésére irányult. Az ellenőrzésbe vont szolgáltatók egy jól definiált módszertan szerint kerültek kiválasztásra. Az ellenőrzés 2014-ben is 5 blokkban történt, amely során az alábbi ellátási szegmensek ellenőrzésére került sor:
1. blokk: fekvőbeteg szakellátás
2. blokk: járóbeteg szakellátás+gyógyászati segédeszköz utalványozási gyakorlat
3. blokk: fogászati alap- és szakellátás
4. blokk: háziorvosi alapellátás+otthoni szakápolás és hospice ellátás elrendelésének gyakorlata
5. blokk: betegszállítás

Az ellenőrzések lezárultak és a területi hivatalok visszajelzése alapján megállapítható, hogy a szolgáltatók pozitívan fogadták az ellenőrzés munkatársait. A bázis ellenőrzés elérte célját, a szolgáltatók bizalommal fordulnak az OEP-hez és ez ismételten megerősíti, hogy ezt a munkát folytatni szükséges. A kibővített bázis ellenőrzésen túl számos, döntően az OEP szervezeti egységeitől, hatóságoktól érkezett megkeresések valamint egyedi bejelentésekből, panaszokból egyaránt kezdeményezett az OEP szakfőosztálya átfogó ellenőrzéseket.

Országos kórházi összehasonlító ellenőrzés
A Szaktárca kérésének eleget téve rendelt el az OEP egy országos átfogó ellenőrzést 2013. őszén, melynek célja, hogy a legnagyobb betegellátási forgalommal rendelkező kórházakról összehasonlítható információkkal rendelkezzen, amely viszonyítási alapul szolgálhat működésük tárgyilagos megítéléséhez. Az ellenőrzés, amely két részből állt, áthúzódott 2014-re.

Az intézmények vezetői egy üzemgazdasági szemléletű kérdőív kitöltésével nyilatkoztak a kórházak fontosabb gazdálkodási paramétereiről, a kontrollingben használatos jellemző mutatókról. Ezzel párhuzamosan egy átfogó helyszíni orvos szakmai ellenőrzésre került sor, amely alapvetően a fekvőbeteg szakellátási esetek validitásának a vizsgálatára terjedt ki.

2014. további ellenőrzései
Az OEP Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztálya (EOSZEF) a társfőosztályi megkeresések alapján több nagyobb volumenű ellenőrzést kezdeményezett.

- A Speciális Finanszírozási Főosztály kérésére ellenőrzést végzett a primer immunhiányos állapotok (PID) szubsztitúciós kezelésére alkalmazott humán

immunglobulin készítmények alkalmazásával kapcsolatban, a colorectalis carcinóma terápiájában alkalmazott 3 hatóanyag (cetuximab, panitumumab, bevacizumab) finanszírozhatóságához kapcsolódóan, valamint a palivizumab alkalmazásával kapcsolatban.

- Több nagyobb volumenű gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos ellenőrzés is zajlott, amelyeket részben az Ártámogatási Főosztály felkérésére, részben utóellenőrzés keretében, valamint a területi hivatalok jelzése alapján indított az EOSZEF. Vény- és készletellenőrzésre került a NUTROPINAQ gyógyszerkészítmény elszámolt forgalma, mely a gyártó nyilvántartása szerint jelentősen eltért az általuk értékesített forgalomtól. Az eltérés vény- és készletellenőrzés keretében lett vizsgálva. Szintén vény- és készletellenőrzéssel vizsgálta a roziglitazonnak a készítmény forgalomba hozatali engedélyének visszavonását követő elszámolásai okát. Szintén az Ártámogatási Főosztály kérésére ellenőrizte az EOSZEF egy budapesti patikában jelentősen megugrott Xanax tabletta forgalmát, melynek során szabálytalan felírások igazolódtak.
- AZ EOSZEF előző évi patikai készletellenőrzéseit folytatva utóellenőrzéseket folytatott le azokban a patikákban, ahol nagymértékű készleteltérés mutatkozott. Az ellenőrzés helyszíni orvosszakmai ellenőrzéssel párosult a felíró orvosoknál, betegdokumentációk átvizsgálásával, és az érintett biztosítottak nyilatkoztatásával. A feltárt szabálytalanságok nyomán a NAV nyomozást rendelt el.
- Szintén bejelentés alapján tárt fel az OEP szabálytalan, szakképesítés hiányában történt gyógyszerfelírást több kórházban.
- Bejelentésre indult ellenőrzés egy idősotthonban felíró pszichiáter szakorvos tevékenységével kapcsolatban. A fiktív gyógyszerfelírások és elszámolások igazolódtak, emiatt büntető feljelentés megtételére is sor került.
- Több, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ellenőrzés is történt. Országosan került ellenőrzésre a Meyra antidecubitus ülőpárnák forgalmazása, betegnyilatkozatok felvételével.
- Egy gyógyászati segédeszköz forgalmazóval kapcsolatban szintén betegszintű adatfelvétel igazolt fiktív kötszer kiszolgálást, amelynek igazolására az EOSZEF ellenőrzést rendelt el a felíró orvosok irányában.
- Az OEP ellenőrzést folytatott üzemi balesettel összefüggésben rendelt gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban. Az ellenőrzés a betegtérítési díjakról kiállított bizonylatok szabálytalanságát tárta fel néhány forgalmazónál, amelyről a tájékoztatást az illetékes NAV felé az OEP megtette.
- Panaszbejelentés alapján indult ellenőrzés C1 és C2 típusú egyedi készítésű gyógycipők kiszolgálásához kapcsolódóan, a felíró orvosok munkahelyén és a forgalmazónál, illetve betegnyilatkozatok felvételére is sor került. Az ellenőrzés feltárta, hogy felírt C2 ortopédcipő számos esetben nem felelt meg a jogszabályi előírásnak.

- Az Országos Mentőszolgálat győri betegirányító egysége élt panasszal 2 betegszállító szolgáltatóval kapcsolatban. A betegszállító cégek nem a jogszabályokban valamint a szerződésükben foglaltak szerint látták el feladataikat. A bejelentésre ellenőrzés indult. A szolgáltatók az ellenőrzést követően felmondták a finanszírozási szerződésüket. Az OEP záró-ellenőrzés lefolytatását kezdeményezte.
- NAV megkeresésre is indított ellenőrzést az OEP egy hévízi gyógyfürdőben nyújtott gyógyászati ellátásokkal kapcsolatban, mert felmerült a gyanú, hogy a szolgáltatónál nincsen megfelelő képesítéssel rendelkező szakember. A vizsgálat még nem zárult le.
- Adatszolgáltatás is történt a NAV felé egy gyógyászati segédeszköz forgalmazó céggel kapcsolatos panaszbejelentés miatt.

A szakmai ellenőrzés 2014-ban számokban

Ellenőrzés indoka	Ad hoc	Országos ellenőrzési terv szerint	TH saját hatáskörében indított	Összesen
Elemzés	177	1214	2281	3672
Hivatalos megkeresés	136	1825	160	2121
Korábbi ellenőrzés	3	16	57	76
Közérdekű bejelentés	29	1	5	35
Panasz	25	-	10	35
Összesen	370	3056	2513	5939

Az OEP 2014-ben 5 939 helyszíni szakmai ellenőrzést folytatott országszerte, ezek egy része közérdekű bejelentésre, panaszra indult. A beérkezett panaszok közül kiemelhető a betegszállítással kapcsolatban tett nagyszámú biztosítotti panasz. Betegéletútban felfedezett vitatott ellátásokkal kapcsolatban is számos ellenőrzés történt, amely egyaránt érintett fekvő, járóbeteg szakellátást, fürdőgyógyászati ellátásokat, továbbá vitatott gyógyszerfelírásokat egyaránt. Ezek minden esetben kivizsgálásra kerültek. Az elmúlt évben fogászati kezeléssel összefüggésben is számos megkeresés érkezett, ami összefügg egyes fogtechnikai eszközök egyedi méltányossági kérelmének elbírálásával.

Utazási költségtérítés

Az utazási költségtérítés címen az E. Alap 2014. évi költségvetési előirányzata 5 240,0 millió forint, a tényleges kiadás 5 201,2 millió forint volt, ami az előirányzat összegénél 38,8 millió forinttal kevesebb, azonban a 2013. évi kiadáshoz képest 233,7 millió forint emelkedést mutat. Az emelkedés a közlekedési társaságok által megemelt menetjegyárakkal magyarázható.

A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások és külföldön történő ellátások

A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások és külföldön történő ellátások kiadási jogcímcsoporton belül egyrészt a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások, másrészt a külföldi sürgősségi gyógykezelések költségei kerültek elszámolásra. A jogcímcsoport teljesítése a 2014. évben 12 049,6 millió forint volt, amely az előirányzatot 2 498,4 millió forinttal, az előző évi tényadatot 5 039,2 millió forinttal haladta meg. A jogcímcsoporton belül a 2013. évhez képest új előirányzatként jelent meg a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése elnevezésű előirányzat, valamint a 2013. évben még a pénzbeli ellátások között nyilvántartott, külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások előirányzat átvezetésre került ebbe a jogcímcsoportba.

A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül és Sürgősségi ellátás EGT-n kívül jogcímeinek a kiadásai 2014. évben összesen 10 034,7 millió forintot tettek ki a 6 551,2 millió forintos előirányzattal szemben. A teljesítésen belül a legnagyobb arányt (96,9 százalék) az EU-val kapcsolatos elszámolások jelentették. A teljesítés az előző évhez képest 3 200,7 millió forintos növekedést mutat. A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások magukban foglalják:

- azon országok biztosítottainak magyarországi sürgősségi ellátásainak költségét melyekkel hazánknak hatályos egészségügyi tárgyú megállapodása van,
- a hatályos magyar-montenegrói, magyar-bosnyák, magyar-horvát, valamint a magyar-szerb kétoldalú elszámolásos egyezmények értelmében, a Magyarországon felmerült sürgősségi ellátások finanszírozási kiadásait, valamint a montenegrói, bosnyák, horvátországi és szerbiai egészségbiztosítási összekötő szervek részére a magyar biztosítottak montenegrói, boszniai, horvátországi és szerbiai sürgősségi ellátása után felmerült kinti költségek OEP részéről történő megtérítését,
- a közösségi szabályok alapján az EGT állampolgárok magyarországi orvosilag szükséges ellátásainak költségét (magyar biztosítási jogviszonnyal rendelkezők esetén teljes körű ellátás is beleértendő),
- a közösségi szabályok alapján az EGT tagállamok betegbiztosítási összekötő szerveitől beérkező megtérítési igényekben feltüntetett költségek teljesítését (magyar biztosítottak külföldön történő ellátása).

A külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000,0 millió forintos előirányzaton a 2014. évi teljesülés mindössze 0,3 millió forint volt.

A külföldön történt speciális egészségügyi ellátások előirányzat terhére történik a külföldi sürgősségi ellátások költségeinek utólagos megtérítése, amelynek gyakorlata az Ebtv. 27.§ alapján Magyarország EU-csatlakozása után is változatlan maradt. A korábbi gyakorlaton túl azonban valamennyi olyan EGT tagállamban nyújtott ellátás is

ide tartozik, amelyet a magyar állampolgárok megfelelő formanyomtatvány hiányában térítési kötelezettség mellett vettek igénybe. A közösségi rendelet alapján azonban ez utóbbi esetben nem a magyar belföldi költség mértékét, hanem azt az összeget kell visszatéríteni, amelyet a kisegítő teherviselő fordított volna az ellátásra akkor, ha azt a megfelelő formanyomtatvánnyal vették volna igénybe. A visszatérítendő összeg a magyar belföldi költség helyett a külföldi biztosító által meghatározott összeg (a kinti finanszírozási mérték) lett, amely jóval magasabb értékű a magyar költségeknél. Ezen előirányzat terhére történik az Ebtv. 27.§ (5) alapján, a külszolgálatot teljesítők 85 százalékos elszámolása is.

A 2014. évi előirányzat 300,0 millió forint, ezzel szemben a teljesítés 200,9 millió forint volt. A felhasználás több, mint 67,1 százalékát, 134,9 millió forintot a külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők 85,0 százalékos elszámolása adta. A magyar biztosítottak utólagos költségmegtérítése a 2013. évi teljesítéshez képest a 2014. évben, 20,2 millió forintról 65,9 millió forintra növekedett.

A külföldi gyógykezelés címén 1 700,0 millió forintos előirányzattal szemben a teljesítés 1 813,7 millió forint volt, amely az előirányzathoz képest 113,7 millió forinttal, az előző évi teljesítéshez képest 248,1 millió forinttal magasabb. Tekintettel az uniós elszámolás szabályaira, a 2014. évben kifizetett fenti összeg a 2-3 évvel korábban igénybe vett ellátásokra vonatkozik. A magyar biztosítottak részére *a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről* szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint *a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól* szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján külföldön történő gyógykezelés abban az esetben valósulhat meg, amennyiben Magyarországon nincsenek meg a gyógyulás feltételei és a külföldi ellátással esély lehet a gyógyulásra.

2014. évben 602 külföldi gyógykezelésre vonatkozó kérelem került elfogadásra. Az elmúlt évben a kiadások tekintetében a változás a költségigényesebb ellátások felé mozdult el, de az alacsonyabb költségű ellátások száma is, mint például a molekuláris genetikai vizsgálat, növekedett. A kiadott engedélyek alapján Svájcban, a zürichi klinikán 12 fő összetett gerincműtétét, továbbá 40 fő DOTATOC kezelését jellemzően a baseli centrumban végezték el. 2014. évben az Amerikai Egyesült Államokban 18 fő esetében történt magas költségigényű ellátás. 2014. évben 23 magyar biztosított tüdőtranszplantációja valósut meg a bécsi Allgemeines Krankenhausban, élődonoros májtranszplantációra pedig 12 esetben került sor Essenben és Kielben. Eredményes keresést követően 81 esetben történt őssejt készítmény Magyarországra történő szállítása, melyet követően az allogén őssejt átültetés magyarországi egészségügyi intézményben történt.
Magyarország Eurotransplant tagságával összefüggésben a 300,0 millió forintos előirányzattal szemben mindösszesen 246,4 millió forint került felhasználásra.

Természetbeni ellátások céltartaléka

2014. évben a Kt. 3 800,0 millió forint előirányzatot tartalmazott a természetbeni ellátások céltartalékára, amelynek felhasználásáról a 17. § (3) bekezdés rendelkezett. Ennek megfelelően a teljes összeg átcsoportosításra került a gyógyító-megelőző ellátás jogcímre.

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

Az alcím együttes felhasználása 12 898,1 millió forint volt, amely az előirányzatnál 211,9 millió forinttal kevesebb, az előző évi tényszámnál pedig 73,3 millió forinttal több. 2014. évben az egészségbiztosítás egyéb kiadásai jogcím tartalmazta az orvosspecifikus vények előirányzatát is.

A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés jogcímre fordított kiadás 1 363,7 millió forint volt, amely az előirányzatot 10,9 millió forinttal, az előző évi tényszámot 14,1 millió forinttal haladta meg.

A postaköltség tárgyévi felhasználása 2 903,1 millió forint, amely az előirányzatnál 23,1 millió forinttal több, az előző évhez képest 12,0 millió forinttal kevesebb.

Az egyéb kiadások jogcím 800,0 millió forintos előirányzata 531,3 millió forintra teljesült. A jogcímen belül az orvosspecifikus vényekre fordított kiadás 350,5 millió forint volt, amely az előző évi tényszámnál 4,3 százalékkal alacsonyabb**.**

A gyógyszertárak juttatása jogcím 2014. évi tervezett előirányzata 3 600,0 millió forint, a teljesítés előirányzati szinten alakult. A *biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól* szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 44/A. §-a szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár juttatásban részesülhet.

Az *egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról* szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GyKr.) 8. §-a szerint a gyógyszertár juttatásban részesül, amennyiben az adott negyedévben elszámolt készítmények alapján a preferált kiadási aránya meghaladja a 35 százalékot.

A gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím 2014. évi tervezett előirányzata 4 500,0 millió forint, a teljesítés előirányzati szinten alakult. A Gyftv. 44/B. §-a szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár az általa nyújtott, betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot elősegítő szolgáltatásaiért szolgáltatási díjban részesül. A GyKr. 8/A. §-a alapján szolgáltatási díjban minden gyógyszertár részesül, amely támogatással rendelkező készítményt számol el.

Vagyongazdálkodás kiadásai

A vagyongazdálkodás kiadási előirányzata 15,0 millió forint volt, a kifizetés 9,1 millió forint, ami 5,9 millió forinttal kevesebb az előirányzathoz képest. A kiadások, melyek döntően az MNV Zrt. részére kifizetett ingatlanfenntartással kapcsolatos költségeket, valamint értékbecslést, ingatlan kezelési díjakat, közjegyzői díjat és jogi szolgáltatás igénybevételét tartalmazzák - 2014. évre az MNV Zrt.-OEP-ONYF-NAV megállapodás hiányában nem kerültek kiszámlázásra. Ezek a költségek a megállapodás aláírását követően 2015. évben kerülnek elszámolásra.

Működési célú kiadások

adatok millió forintban

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi törvényi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. az eredeti előirányzat %-ában
Egészségbiztosítási költségvetési szervek kiadásai	**10 653,3**	**8 877,1**	**11 244,2**	**9 716,6**	**109,5**
Működési költségvetés	**9 596,6**	**8 677,1**	**10 321,7**	**9 162,8**	**105,6**
Személyi juttatás	4 985,3	5 033,0	5 155,3	4 953,2	98,4
Munkaadókat terhelő járulékok	1 279,7	1 269,2	1 474,9	1 364,1	107,5
Dologi kiadás	3 135,3	2 199,9	3 390,5	2 630,3	119,6
Egyéb működési célú kiadások	196,3	175,0	301,0	215,2	123,0
Felhalmozási költségvetés	**1 056,7**	**200,0**	**922,5**	**553,8**	
Beruházások	1 050,8	200,0	761,1	529,5	264,8
Felújítás	0,0		140,4	9,1	
Egyéb felhalmozási kiadások	5,9		21,0	15,2	

A működési kiadások fejezeti szintű eredeti kiadási előirányzata 8 877,1 millió forint. A módosított előirányzat 11 244,2 millió forint, a teljesítés 9 716,6 millió forint, amely 9,5 százalékkal több az eredeti előirányzatnál. Az előirányzat-módosításokra és átcsoportosításokra a felügyeleti engedélyek és saját hatáskörű rendelkezések alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor.

Az előirányzat összesen 2 367,1 millió forintos módosítására, növelésére – hatásköri bontásban – az alábbiaknak megfelelően valósult meg:

- 100,8 millió forint Kormány hatáskörben,
- 34,2 millió forint fejezetet irányító szerv hatáskörben,
- 2 232,1 millió forint intézményi hatáskörben

történő emelés.

A központi hivatali szerv előirányzatát növelte az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásának engedélyezése, illetve a többletbevétel. A további jelentősebb egyéb előirányzat módosítások a pénzeszköz átvételeknél jelentkező többletforrásokkal (Prémiumévek Program fedezete, egyszeri kereset kiegészítés), valamint projektekre kapott támogatásokkal (EURIPID projekt, EKOP, ÁROP kiadásai) összefüggő előirányzat növeléséhez kapcsolódnak.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat a működési költségvetésben 49,0 millió forint zárolását rendelte el. A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a zárolás visszavonását rendelte el, így a működési költségvetés kiadási előirányzata év végén megegyezett az eredeti előirányzattal (8 877,1 millió forint).

A kiadások 65,0 százalékát 6 317,3 millió forintot a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 27,1 százalékát 2 630,3 millió forintot dologi kiadások, 2,2 százalékát 215,2 millió forintot az egyéb működési célú kiadások, a 5,4 százalékát 529,5 millió forintot a beruházások, 0,1 százalékát 9,1 millió forintot a felújítások, 0,2 százalékát 15,2 millió forintot az egyéb felhalmozási célú kiadások képezik.

A személyi juttatások módosított előirányzata 5 155,3 millió forint, amely 122,3 millió forinttal növekedett az eredeti előirányzathoz (5 033,0 millió forint) képest. Személyi kiadásokra 4 953,2 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzat-emelés fedezetét fejezeti hatáskörben a prémiumévek program keretében a személyi juttatásokra fordítható 42,3 millió forint, az egyszeri kereset-kiegészítésre engedélyezett 37,0 millió forint, továbbá az EKOP és az ÁROP Projektek támogatásának személyi juttatásokra fordítható 59,8 millió forint, illetve 33,1 millió forint pénzeszközök átadásaként – EU költségvetéséből negyedévenkénti – átadott összegei biztosították. A személyi juttatásból munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 98,8 millió forint – előirányzatok rendezése miatt –, a dologi kiadásokra 72,3 millió forint – zárolás, a 2014. évi közigazgatási továbbképzés normatív hozzájárulás befizetése miatt –, az egyéb működési célú kiadásokra 35,4 millió forint összegű átcsoportosítás történt – részben a zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetési kötelezettsége miatt. Az előirányzatot 156,6 millió forinttal növelte az előző évi előirányzat-maradvány. Az előirányzaton 202,1 millió forint kiadási megtakarítás jelentkezett a módosított előirányzathoz képest.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1 269,2 millió forint, amely az év során 205,7 millió forinttal emelkedett és 1 474,9 millió forintra módosult. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból az egyéb működési célú kiadásokra történő előirányzat

átcsoportosítás egyrészt az előirányzatok rendezése, másrészt a zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetési kötelezettségéből adódott.

A személyi juttatások után 1 223,0 millió forint szociális hozzájárulási adó, 55,0 millió forint rehabilitációs hozzájárulás, 39,4 millió forint egészségügyi hozzájárulás, 6,3 millió forint táppénz-hozzájárulás és 40,4 millió forint munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó került kifizetésre.

A teljesítés 1 364,1 millió forint, amely a módosított előirányzathoz képest 110,8 millió forint megtakarítást jelent.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2 199,9 millió forint, amely évközben 3 390,5 millió forintra módosult. A teljesítés adata 2 630,3 millió forint. A módosított előirányzathoz képest a megtakarítás 760,2 millió forint. A megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A dologi kiadásokon belül a legszámottevőbb kiadások az alábbiak:

- 1 359,9 millió forint összegben az egészségbiztosítási költségvetési szervek működtetéséhez szükséges szolgáltatási kiadások (gáz, áram, táv hő- és meleg vízszolgáltatás, valamint a víz és csatornadíjak, egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak, bérleti díj, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai, pénzügyi szolgáltatások, vásárolt élelmezés, szállítási szolgáltatások),
- 623,4 millió forint összegben a kommunikációs szolgáltatások,
- 522,2 millió forint összegben különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (pl. általános forgalmi adó).

Az egyéb működési célú kiadás eredeti előirányzata 175,0 millió forint, módosított előirányzata 301,0 millió forint és teljesítése 215,2 millió forint.

Ezen jogcímen jelentősebb kiadások a következők:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
  - Nemzetközi tagsági díj: 14,4 millió forint,
  - Elvonások, befizetések – zárolt álláshelyek, munkahelyvédelmi akció terv befizetés – 2,2 millió forint,
  - GYEMSZI részére gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szakértői díja 161,6 millió forint,
  - KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség – EKOP projekt továbbutalás 7,1 millió forint,
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:*
  - NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt – EKOP projekt továbbutalás 17,4 millió forint,

- Működési célú pénzeszközátadás nemzetközi szervezeteknek (EURIPID-ből továbbutalás Gesundheit Österreich GmBH részére 12,5 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások fejezeti szinten 15,2 millió forint. Ez a 2014. évben a dolgozóknak visszafizetési kötelezettség mellett adott kamatmentes lakásépítési kölcsönök összegét tartalmazza.

A beruházás eredeti előirányzata 200,0 millió forint, a módosított előirányzat 761,1 millió forint volt, amely a 2013. évi előirányzat-maradványból (428,6 millió forint), illetve az előirányzat átcsoportosításából keletkezett. A teljesítés 529,5 millió forint. A 231,6 millió forint megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt.

A tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozására 529,5 millió forint került felhasználásra, amelyből az általános forgalmi adó 112,6 millió forint volt.

A beruházások beszerzése:
- immateriális javak 252,1 millió forint
  - vagyoni értékű jogon belül (ITP 2000, Szoftver licenc beszerzés),
  - szellemi terméken belül (Forrás.NET integrált pénzügyi és számviteli rendszer bevezetése az ellátás területén, OEP részére fejlesztett alkalmazásoknak a jogszabály követése),
- ingatlanok beszerzése 138,6 millió forint
  - kazán rekonstrukció: 107,0 millió forint,
  - gépterem tűz és behatolás elleni védelmének megerősítése: 24,1 millió forint,
  - erősáramú hálózat betáplálása, klíma: 7,5 millió forint
- 26,2 millió forint informatikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, melyből
  - informatikai eszközök: 23,4 millió forint,
  - 200 ezer forint alatti tárgyi eszközök beszerzése: 2,8 millió forint.

Előirányzat-maradvány alakulása

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére visszahagyásra került az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI. 30.) Kormány határozat (továbbiakban: Korm. határozat), valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 301,4 millió forint összeg maradvány, továbbá a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással terhelt, de 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült

költségvetési maradványok 466,6 millió forint, összesen 768,0 millió forint költségvetési maradvány.

A 2014. évi 1 448,1 millió forint költségvetési maradványból 1 286,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 162,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 72,0 százaléka, azaz 926,3 millió forint a tárgyévben keletkezett, míg 28,0 százaléka, azaz 359,7 millió forint az előző évek maradványa.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1 286,0 millió forint, melynek megoszlása:

- felhalmozási kiadások 368,1 millió forint,
- egyéb működési célú kiadások 53,0 millió forint,
- személyi juttatások 67,8 millió forint,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,1 millió forint,
- dologi kiadások 714,0 millió forint.

A központi költségvetésből finanszírozott és az egészségbiztosítás által folyósított ellátások alakulása

A közgyógyellátásra fordított kiadás a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz támogatáshoz, valamint a gyógyfürdő ellátáshoz kapcsolódóan 17 645,2 millió forint volt, amely 1 207,0 millió forinttal kevesebb az előző évi összegnél. A központi költségvetésből ténylegesen 17 640,0 millió forint megtérítést kapott az Alap. A különbözet (5,2 millió forint) átutalásáról a zárszámadási törvényjavaslat rendelkezik.

A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számla igénybevételének éves alakulása

2014. év

millió forintban

Hónap	Nyitó Egyenleg	Záró Egyenleg	Legmagasabb érték	Átlagos Hitelállomány	Éves halm. átlagos hitelállomány
Január	0,0	0,0	75 741,3	17 605,3	
Február	0,0	0,0	49 097,3	12 122,9	14 864,1
Március	0,0	0,0	42 445,4	9 366,3	13 031,5
Április	42 272,3	4 040,8	47 356,2	13 254,0	13 087,1
Május	4 040,8	0,0	39 845,9	6 639,0	11 797,5
Június	0,0	0,0	41 151,8	10 561,5	11 591,5
Július	40 689,3	0,0	42 441,7	11 902,5	11 635,9
Augusztus	49 789,6	0,0	50 712,8	11 205,6	11 582,1
Szeptember	44 686,8	0,0	51 283,5	14 036,3	11 854,8
Október	45 004,8	0,0	49 704,4	13 402,6	12 009,6
November	0,0	0,0	44 107,4	10 066,3	11 832,9
December	41 288,4	0,0	50 216,0	13 057,7	11 935,0

A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számla záró egyenlege 0,0 millió forint. A hitelállomány alakulásában jelentős szerepet játszott a költségvetés által havi részletekben több jogcímen átadott pénzeszköz.

Budapest, 2015. június „ ”.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Főigazgató

Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató h.